



Non-Technical Skills for Patient Safety

Wanvimol Kongsuwan, PhD, RN

Head of Perioperative division, Nursing department
Siriraj hospital, Faculty of Medicine Mahidol university

2 October 2026
1:00-3:00 pm.



10 most common sentinel events of 2023: Joint Commission



(Mackenzie Bean, 2024)

No.	Sentinel events for 2021	Report events
1	Fall	48%
2	Wrong surgical site	8%
3	Unintended retention of a foreign object	8%
4	Assault/rape/sexual assault of a patient	8%
5	Delay in treatment	6%
6	Suicide	5%
7	Fire/ burns	4%
8	Medication management	2%
9	Perinatal event	2%
10	Self harm	2%

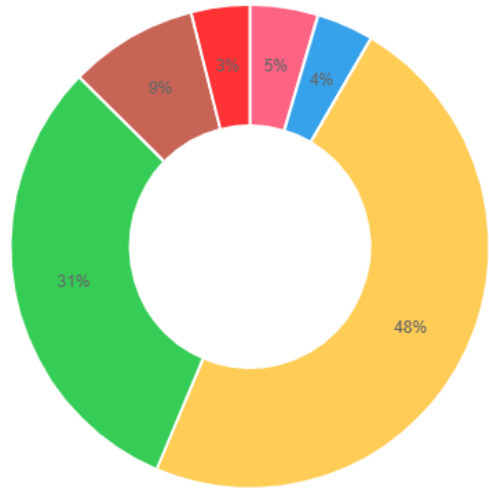


Risk for adverse events in the operating room

- Wrong patient
- Wrong surgery site
- Foreign bodies object retained
- Burns from grounding pads
- Surgical site infections
- Falls
- Nerve injuries from surgery
- Pressure injuries
- Wrong operation

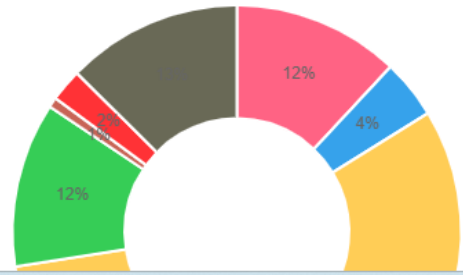
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident

- Safe Surgery
- Infection Prevention and Control
- Medication & Blood Safety
- Patient Care Process
- Line, Tube & Catheter and Laboratory
- Emergency Response



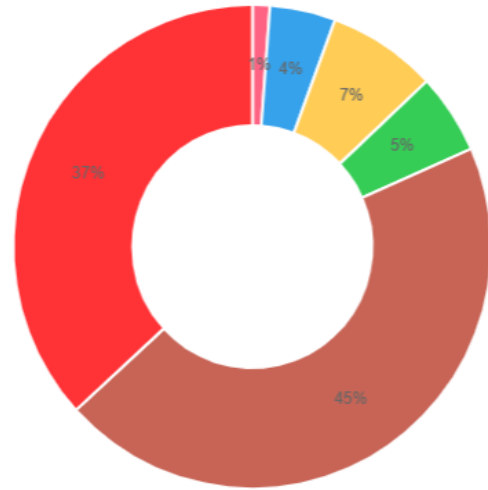
Specific Clinical Risk Incident

- Gynecology & Obstetrics diseases and procedure
- Surgical diseases and procedure
- Medical diseases and procedure
- Pediatric diseases and procedure
- Orthopedic diseases and procedure
- Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure
- Dental diseases and procedure



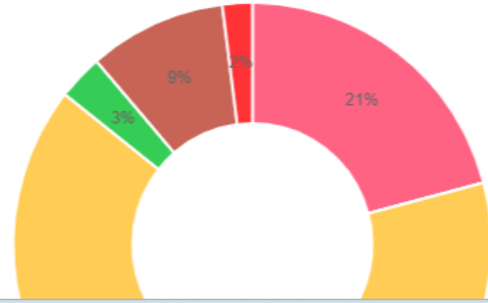
Personnel Safety Goals

- Social Media and Communication
- Infection and Exposure
- Mental Health and Mediation
- Process of work
- Lane (Traffic) and Legal Issues
- Environment and Working Conditions



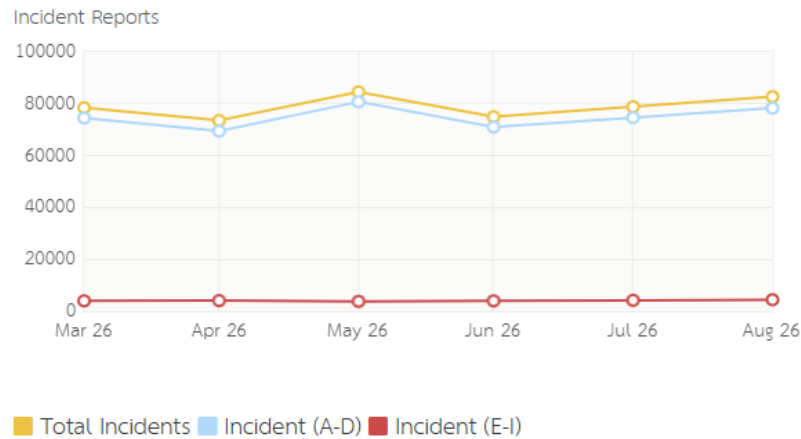
Organization Safety Goals

- Strategy, Structure, Security
- Information Technology & Communication, Internal control & Inventory
- Manpower, Management
- Policy, Process of work & Operation
- Licensed & Professional certificate
- Economy



Preventable & Unpreventable

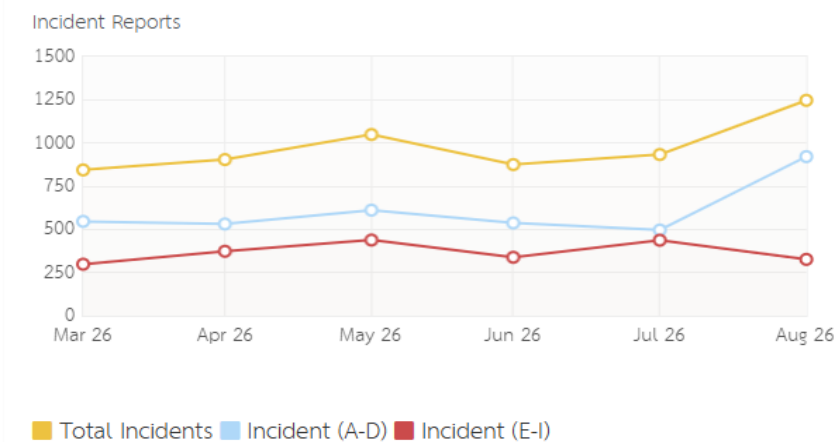
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident



Incident Type	E	F	G	H	I	รวม E-Up	รวม(ระดับ A-I)	ร้อยละ E-Up
Safe Surgery	1730	682	34	41	67	2554	21791	11.72
Infection Prevention and Control	1926	363	1	1	25	2316	18187	12.73
Medication & Blood Safety	2529	416	8	32	29	3014	226678	1.33
Patient Care Processes	6194	1344	101	318	420	8377	146662	5.71
Line, Tube, and Catheter & Laboratory	1340	83	8	28	12	1471	40981	3.59
Emergency Response	3031	1259	128	894	1328	6640	18693	35.52
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้)	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวม	16750	4147	280	1314	1881	24372	472992	5.15

Specific Clinical Risk Incident

Which risks can we control, and which harm can we prevent?



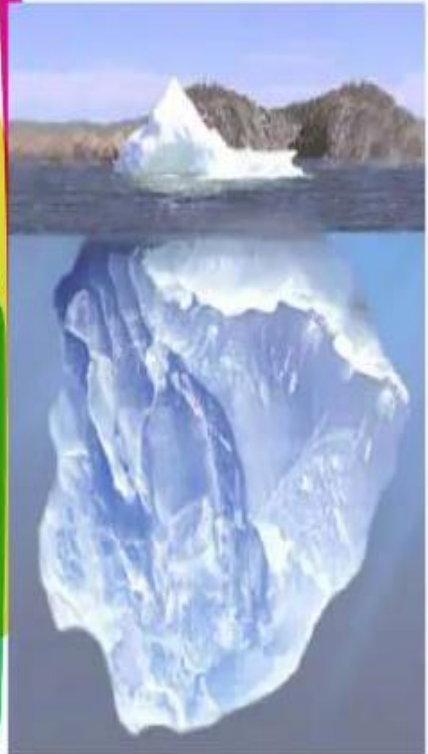
Incident Type	E	F	G	H	I	รวม E-Up	รวม(ระดับ A-I)	ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure	197	25	7	8	16	253	703	35.99
Surgical diseases and procedure	73	58	2	3	6	142	247	57.49
Medical diseases and procedure	783	207	3	72	48	1113	3296	33.77
Pediatric diseases and procedure	192	66	3	23	13	297	688	43.17
Orthopedic diseases and procedure	7	4	1	1	3	16	42	38.10
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure	53	16	0	3	0	72	137	52.55
Dental diseases and procedure	290	26	0	0	1	317	739	42.90
รวม	1595	402	16	110	87	2210	5852	37.76

Risk = hazard x Probability to exposure



การลดภาวะคุกคามและ/หรือลดโอกาสเกิดคือการจัดการความเสี่ยง

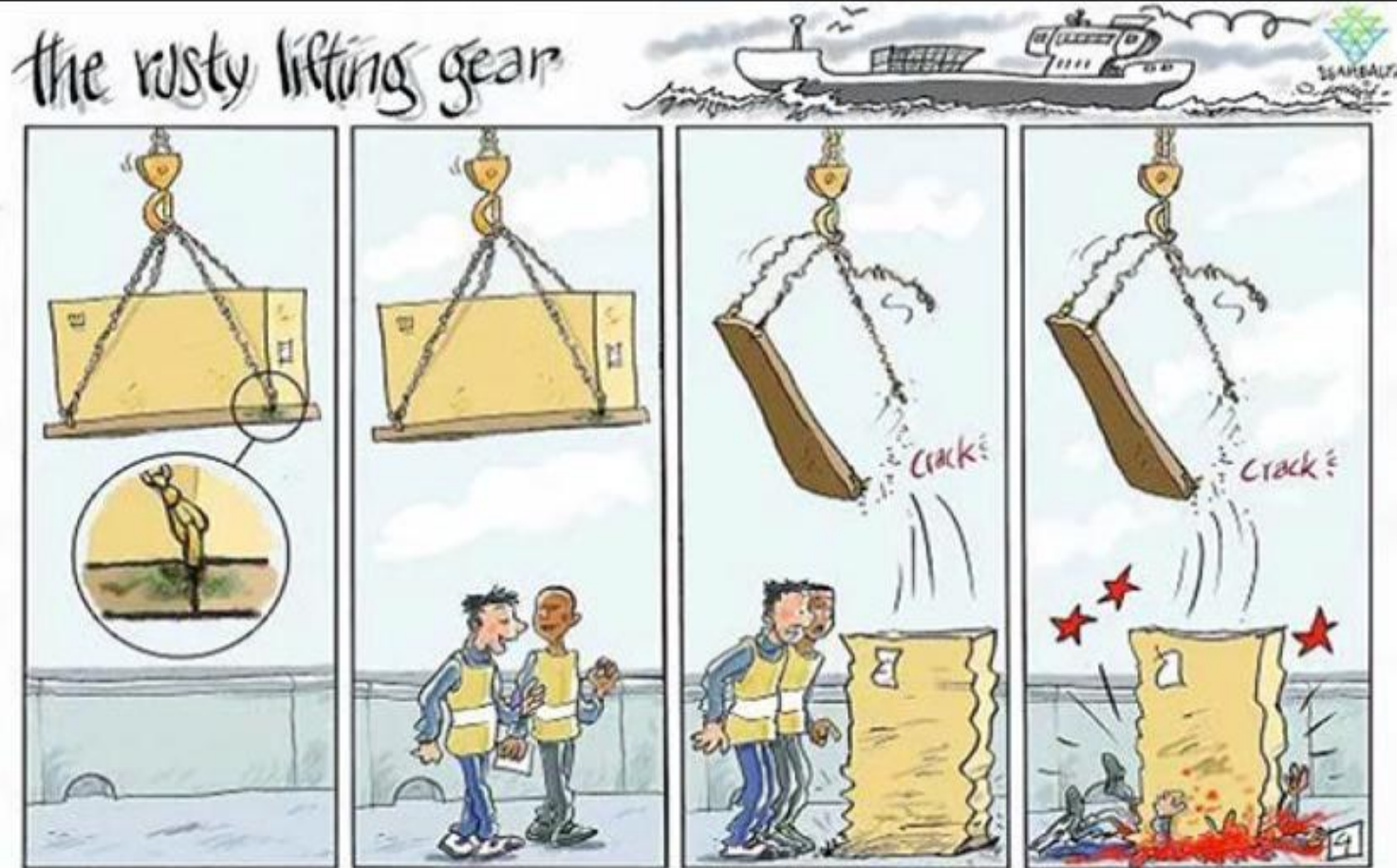
Hazards



- Hazard activities (i.e., behaviors) or conditions that pose threat of harm

Sometimes hazards lie hidden in the system, and sometimes they are quite obvious

www.fppt.info



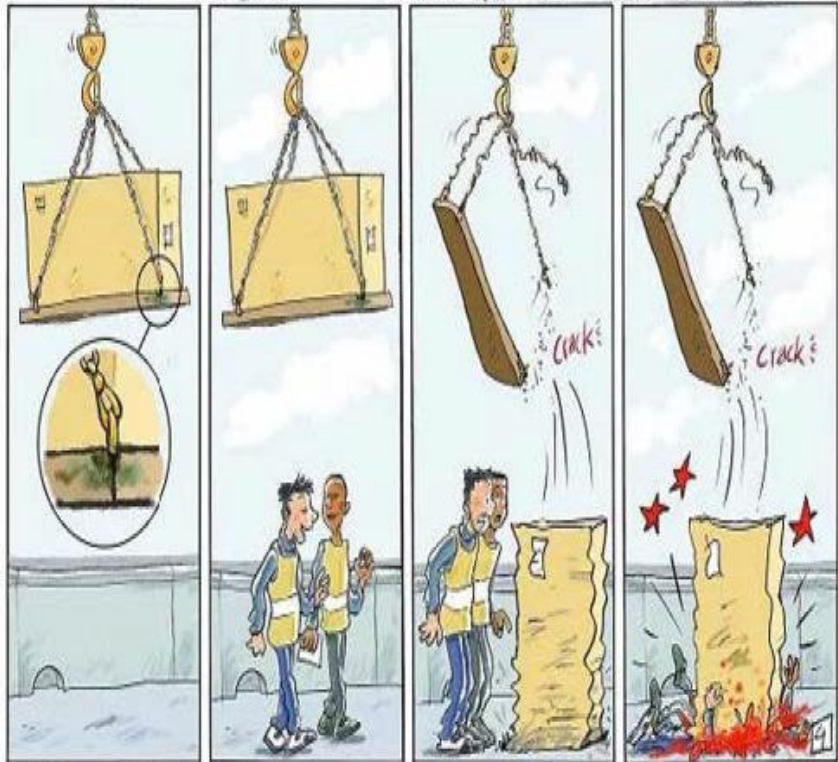
Hazard

Probability to exposure

Incident
No harm

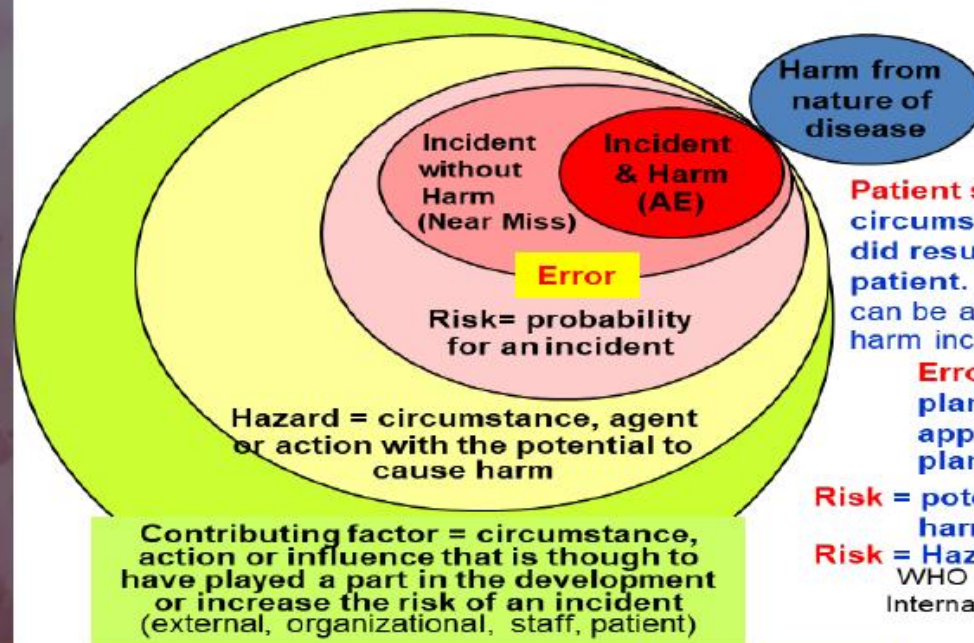
Incident
with harm

the rusty lifting gear



**Risk = Hazard x Probability
of Exposure**

Error, Risk, Harm



Error

Prevention, Mitigation, Acceptability

Risk !!



Patient safety incident = an event or circumstance that could have resulted, or did result, in unnecessary harm to a patient.

can be a reportable incident, near miss, no harm incident, harmful incident (AE)

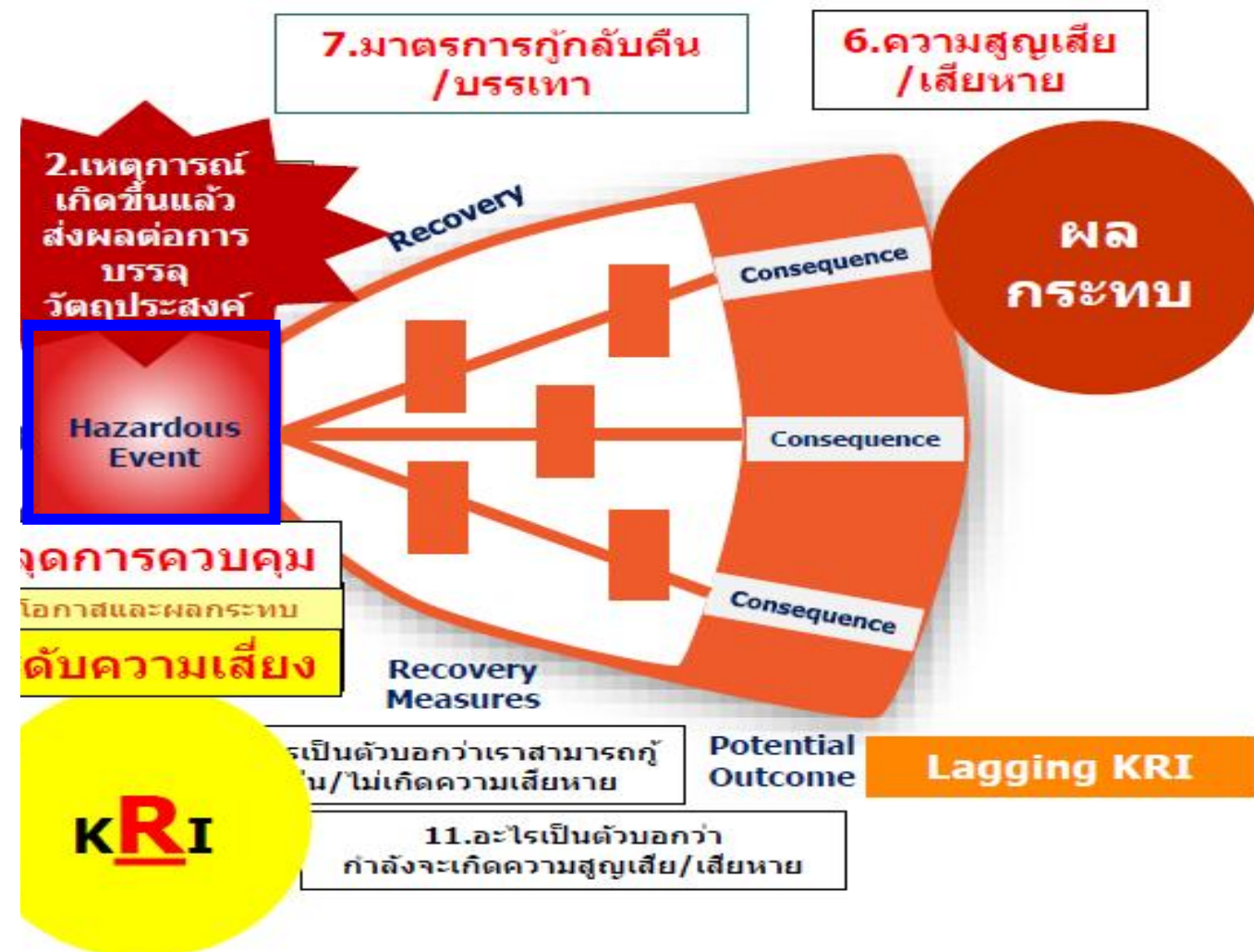
Error = failure to carry out a planned action as intended or application of an incorrect plan

Risk = potential for a hazard to caused harm

Risk = Hazard x Exposure
WHO 2009. Conceptual Framework for the International Classification for Patient Safety

Risk Base Thinking (Reactive RM=RCA)

1.Objective.....KPITarget.....



การวิเคราะห์หุ้บัติการณ RCA

ใครทำ ??
ใครเกี่ยวข้องบ้าง ??

รุนแรงมาก-น้อย ??

Error ตอนไหน ??
เพราะอะไร ?

ผลกระทบกับผู้ป่วย ??

เกิดแล้วทำ
อย่างไร ??

รายงานตอบกลับ
แนวทางเพื่อป้องกัน
การเกิดซ้ำ??



Most Frequently Identified Root Causes of Sentinel Events Reviewed by The Joint Commission by Year

*The majority of events have multiple root causes
(Please refer to subcategories listed on slides 5-7)*

2012 (N=901)		2013 (N=887)		Jan to Jun 2014 (N=394)	
Human Factors	614	Human Factors	635	Human Factors	290
Leadership	557	Communication	563	Leadership	269
Communication	532	Leadership	547	Communication	248
Assessment	482	Assessment	505	Assessment	208
Information Management	203	Information Management	155	Physical Environment	53
Physical Environment	150	Physical Environment	138	Care Planning	38
Continuum of Care	95	Care Planning	103	Information Management	36
Operative Care	93	Continuum of Care	97	Continuum of Care	33
Medication Use	91	Medication Use	77	Operative Care	29
Care Planning	81	Operative Care	76	Health information technology-related	27

Human error=ความผิดพลาดของมนุษย์



Error : ความพลั้งเผลอ หรือ ผิดพลาด

- การทำงานที่**เบี่ยงเบน**ไปจากที่วางไว้ หรือที่ตั้งใจไว้
- การทำงานใดๆที่**ไม่บรรลุผลลัพธ์**ที่ต้องการ อาจเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้

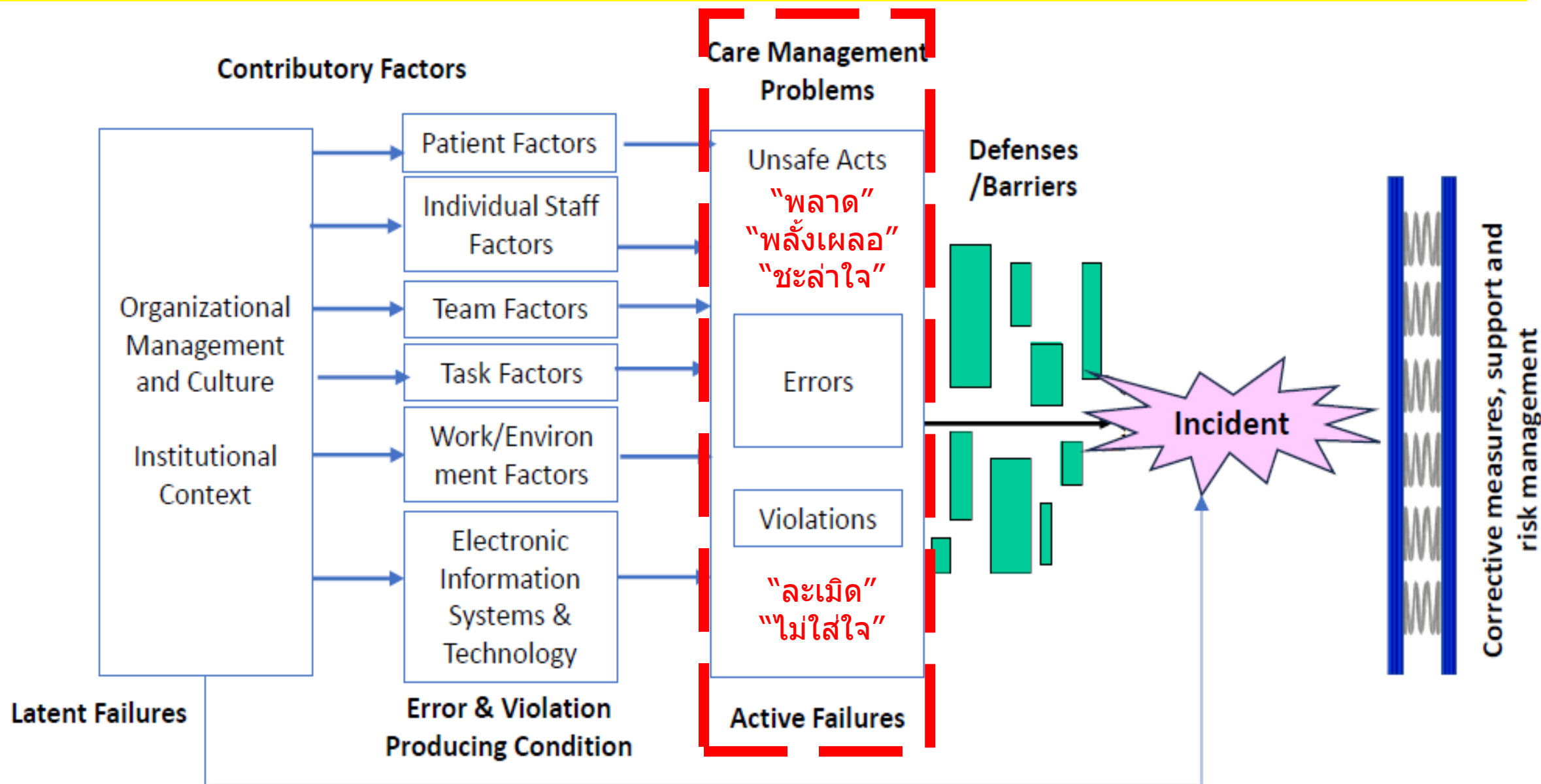
ความตั้งใจ หมายถึง ขณะที่เขากำลังทำนั้น เขา**มีความตั้งใจคิดด้วยสติ**

แต่ด้วยข้อจำกัด ในความรู้หรือประสบการณ์ ทำให้ผลที่ได้ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ เรียกว่า "ผิด" อาจเป็นเพราะ "คิดคำตอบผิด" หรือ "ใช้คำตอบผิด"

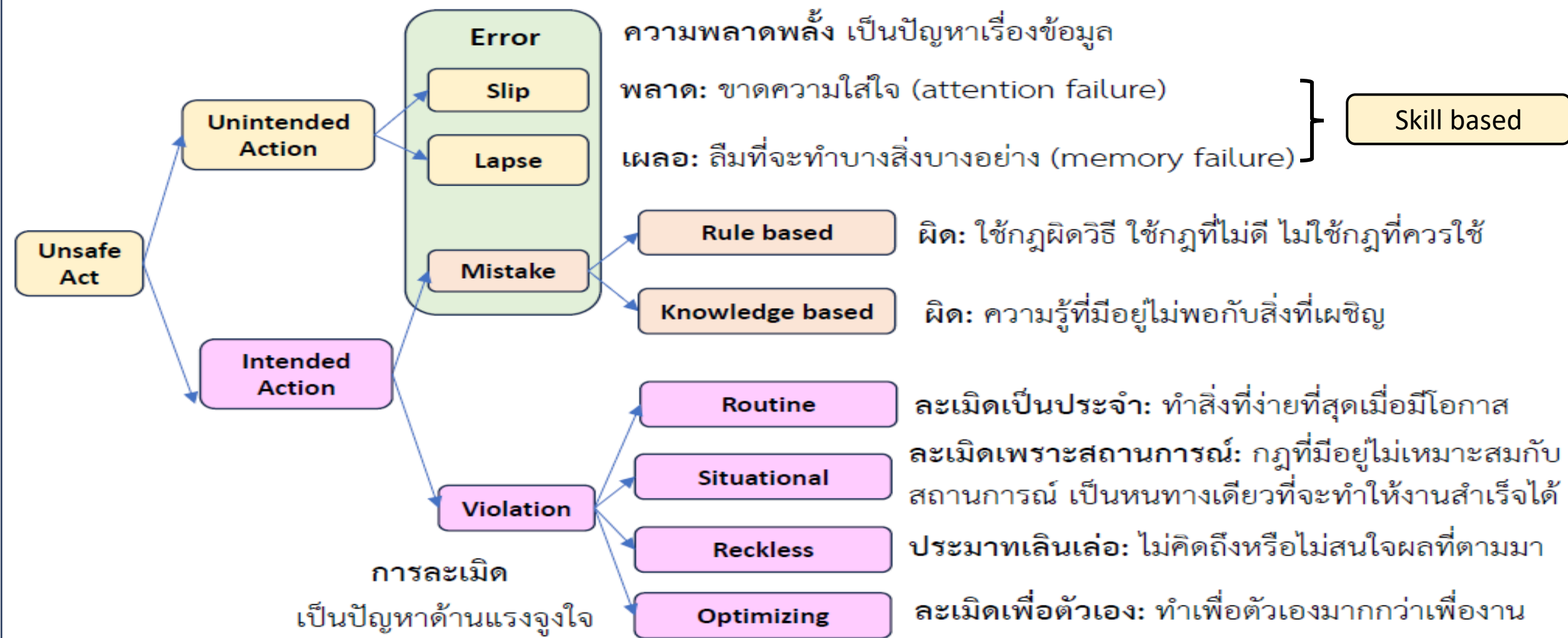
ความไม่ตั้งใจ หมายถึง ขณะที่ทำนั้น ไม่ตั้งใจคิดด้วยสติ/ไม่มีสติ อาจเกิดจาก "ความพลั้งเผลอ" หรือ "หลงลืม" เนื่องจากถูกรบกวน หรือมีความกังวลในใจ ทำให้แผนที่ตั้งไว้ไม่ได้รับการปฏิบัติ



ตัวแบบอุบัติเหตุในองค์กร (Organizational Accident Model)



Human error = Unsafe Act = Care Management Problem



Source: James & Reason & The Human Diver!

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ปัญหาการจัดการดูแล (Care Management Problems - CMPs)



Human error

(ความผิดพลาด
ของมนุษย์)



Unsafe act

(การกระทำที่ไม่
ปลอดภัย)



Care Management Problem

(ปัญหาการจัดการดูแล)

Care Management Problem หมายถึง

การดูแลที่เบี่ยงเบนไปจากขอบเขตที่ปลอดภัยของการปฏิบัติ ซึ่งอาจส่งผลโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์

The London Protocol 2024

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ตัวอย่าง CMP เช่น

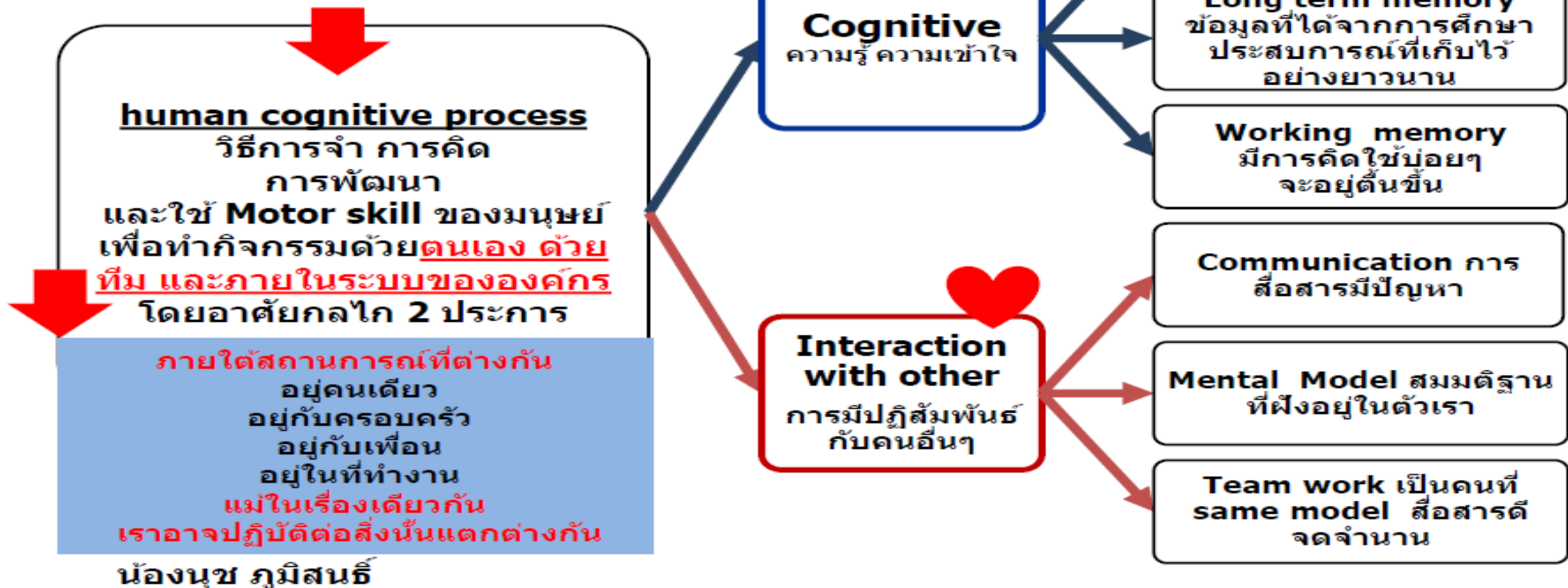
- ไม่มีการเฝ้าระวัง สังเกต หรือลงมือกระทำ
- ล่าช้าในการวินิจฉัย
- ประเมินความเสี่ยงผิดพลาด
- ส่งต่อข้อมูลไม่เพียงพอ
- ไม่สังเกตเห็นความผิดปกติของเครื่องมือ
- ไม่ได้ทำการตรวจสอบก่อนผ่าตัด
- ไม่ปฏิบัติตาม protocol ที่ตกลงกันไว้
- ไม่ขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น
- ไม่กำกับ ดูแลบุคลากรใหม่อย่างเพียงพอ
- ใช้ protocol อย่างไม่ถูกต้อง
- ให้การรักษาผิดตำแหน่ง
- ให้การรักษาผิด
- การตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง

ในสถานการณ์คล้ายๆกัน
ทำไมบางคนพลาด
แต่! บางคนไม่พลาด
???



Human factors science

to understand how
people perform under different
circumstances





SCIENTIFIC REVIEW

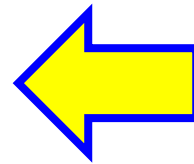
Adverse Events in the Operating Room: Definitions, Prevalence, and Characteristics. A Systematic Review

James J. Jung^{1,2,3} · Jonah Elfassy¹ · Peter Jüni^{3,4} · Teodor Grantcharov^{1,2,3}

Table 4 Proposed framework of intraoperative adverse event types and their examples

Intraoperative adverse event type	Examples
<u>Cognitive</u>	Inappropriate/missed decision, judgment, planning, diagnosis, or treatment. Missed injuries, retained instruments/gauze, and wrong site or wrong patient operations
<u>Behavioral</u>	Communication or coordination failure, and team conflicts
<u>Expertise and technical skills</u>	Suboptimal expertise or technical/psychomotor skills and poor visualization during operations
Tissue injury	Bleeding, tissue tear, organ injury and inappropriate anastomosis
Equipment and medication	Absent or malfunctioning equipment such as cardiopulmonary bypass devices, mechanical ventilators, and implants. Wrong medications or blood products and adverse or allergic drug/transfusion reaction
Environmental and organizational	Distractions, workspace/ergonomic issues, fatigue, absence of team members, unnecessary delays, and transport issues
Patient-related	Events related to patient disease state and difficult operations due to patient anatomy or physiology

Non-technical skills



▶ คือ ทักษะรอบด้านของบุคคล

▶ ประกอบด้วย

- ▶ กระบวนการคิด
- ▶ การสื่อสาร และ
- ▶ ทักษะทางสังคม



ภาพจาก : <https://pipelineperformancegroup.com/blog/non-technical-skills/>

▶ ที่ใช้ร่วมกับ technical skills

▶ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและ

ประโยชน์สูงสุดเมื่อทำภารกิจใดภารกิจหนึ่ง



Non-Technical Skills (NTS) for Enhancing Patient Safety: Achievements and Future Directions

This article was first published in *Japanese Journal of Quality and Safety in Healthcare* 7(4): 360-370, November 2012.

Table 1: Core non-technical skills (21: p454)

Crew recourse

management theory

NTS	Skill components	
Situation awareness	• gathering information • recognising and understanding • anticipating future states	
Decision Making	• defining the problem • identifying options • balancing risks and selecting options • reassessing/reviewing outcomes	
Communication skills	• giving information clearly and concisely • including context and intent • receiving information • identifying and tackling barriers to communication	
Team working	• supporting others • solving conflicts • exchanging information • coordinating activities	
Leadership	• using authority and assertiveness • maintaining standards • planning and prioritizing • managing workload and resources	
Stress management	• identifying symptoms of stress • recognising effects of stress • implementing coping strategies	
Fatigue management	• identifying symptoms of fatigue • recognising effects of fatigue • implementing coping strategies	

Critical eleven minutes : 3 min. Take off & 8 min. Landing



- ทางออกฉุกเฉินใช้ได้แค่ **3 ทางจาก 8 ทาง**
- ล้อหน้าของเครื่องเสียหาย ทำให้เครื่อง **เอียงผิดปกติ** ส่งผลให้สไลด์ท้ายเครื่องจะชันมาก
- ระบบที่ใช้ประกาศบนเครื่องก็ใช้ไม่ได้ ต้องใช้โทรโข่งและ **การตะโกน**
- เครื่องบินรุ่นใหม่ ที่ใช้โครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์ ทำให้มีน้ำหนักเบา แต่แข็งแรงและทนไฟได้ดีกว่าโครงสร้างแบบเดิม จึงทำให้ไฟลุกลามช้าลง
- "เวลาในการตอบสนอง" (Response Times) ของหน่วยดับเพลิง ภัยอากาศยานของสนามบิน เข้าถึงปลายทางได้ภายใน **2 นาที** และต้องไม่เกิน **3 นาที** ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉิน

2 มกราคม 2567

เครื่องบินโดยสาร JAL เที่ยวบิน 516 ชนกับเครื่องบินหน่วยยามฝั่งของญี่ปุ่น ที่สนามบินฮาเนดะ ในกรุงโตเกียว

ผลกระทบ

- เครื่องบินทั้งสองลำเกิดไฟไหม้ เสียหายหมดทั้งคู่
- ลูกเรือบนเครื่องบินหน่วยยามฝั่ง เสียชีวิต 5 ราย และนักบินรอดชีวิต 1 นาย แต่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
- ผู้โดยสารและลูกเรือบนเครื่องบิน JAL **379 คน** ปลอดภัยทั้งหมด สามารถอพยพลงจากเครื่องบินได้ภายใน 3 นาที รอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์

ถอดบทเรียนปัจจัยการรอดชีวิต

- 1) ปฏิบัติตามมาตรฐานการอพยพ
- 2) ความมีระเบียบวินัยของผู้โดยสาร (คนญี่ปุ่น)
- 3) การออกแบบโครงสร้างอากาศยาน และวัสดุที่ใช้ประกอบอากาศยาน



NEW !!

Risk Base Thinking (Proactive & Predictive RM)

1.Objective.....KPITarget.....



น้องนุช ภูมิสนธิ์

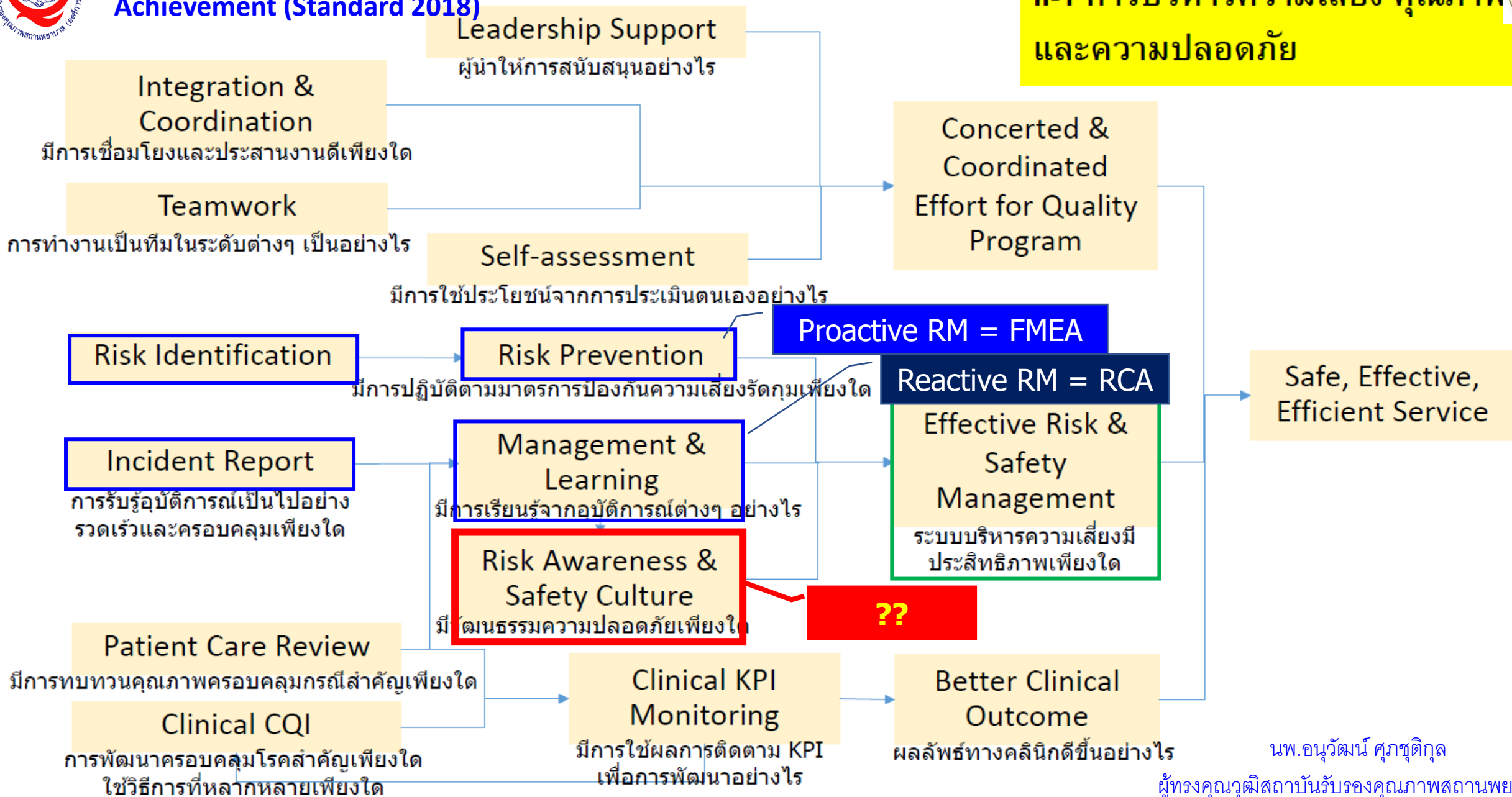
น้องนุช ภูมิสนธิ์



Driver Diagram & Performance Evaluation Guidelines For Higher Achievement (Standard 2018)



II-1 การบริหารความเสี่ยง คุณภาพ และความปลอดภัย



นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

Technical skills

- Aseptic & Sterile Technique
- Nursing knowledge & skills
 - Basic surgery
 - Advanced surgery
- Surgical procedure
- Instrument & Equipment management
- **Surgical Technology**
- Etc.



1) Non technical skills ของพยาบาลห้องผ่าตัดมีอะไรบ้าง?

2) อะไร คือ พฤติกรรมที่สะท้อน Non technical skills ที่ดี ของพยาบาลห้องผ่าตัด ??

3) ทำอย่างไรให้พยาบาลมี Non technical skills ควบคู่ไปกับ Technical skills ?



Thinking ahead of the surgeon. An interview study to identify scrub nurses' non-technical skills

Lucy Mitchell ^{a,*}, Rhona Flin ^a, Steven Yule ^a, Janet Mitchell ^b, Kathy Coutts ^c, George Youngson ^c

^a School of Psychology, University of Aberdeen, Aberdeen AB24 2UB, Scotland, UK

^b Aberdeen Royal Infirmary, UK

^c Royal Aberdeen Children's Hospital, UK

International Journal of Nursing Studies 49 (2012) 201-211

Evaluation of the Scrub Practitioners' List of Intraoperative Non-Technical Skills (SPLINTS) system

Lucy Mitchell ^{a,*}, Rhona Flin ^a, Steven Yule ^a, Janet Mitchell ^b, Kathy Coutts ^c, George Youngson ^a

^a School of Psychology, University of Aberdeen, AB24 2UB Scotland, UK

^b Aberdeen Royal Infirmary, UK

^c Royal Aberdeen Children's Hospital, UK

Journal of Evaluation in Clinical Practice 19 (2013) 317-323

Development of a behavioural marker system for scrub practitioners' non-technical skills (SPLINTS system)

Lucy Mitchell MA MRes,¹ Rhona Flin BSc MSc PhD CPsychol FBPSS FRSE,²
Steven Yule BSc MSc PhD,^{3*} Janet Mitchell RGN DipN MScN,⁵ Kathy Coutts RSCN⁶ and
George Youngson CBE MBChB PhD FRCPE FRCSEd⁴

¹Research Fellow, ²Professor, ³Lecturer, ⁴Professor Emeritus, School of Psychology, University of Aberdeen, UK

⁵Practice Education Facilitator, Aberdeen Royal Infirmary, UK

⁶Theatre Nurse Manager, Royal Aberdeen Children's Hospital, UK

ทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคของพยาบาลห้องผ่าตัดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง*

วรรณวิมล คงสุวรรณ, ปส.ด.¹ รัตติมา ศิริไตรชัย, PhD² ธนพรรณ กุณาสะสิริ, พย.บ.¹
มนันพิทักษ์ ทออบบุญเกิด, พย.บ.¹ วศัญญุตา เวียรชัย, พย.บ.¹

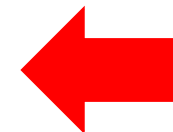


Non-technical skills for surgical team



The Anesthetists' Non-Technical Skill System (ANTS)	Non-technical skills for surgeons (NOTSS)	Scrub practitioners' intraoperative non-technical skill (SPINTS)
1) Task Management	1) Situation Awareness	1) Situation Awareness
2) Team Working	2) Decision Making	2) Communication and Teamwork
3) Situation Awareness	3) Communication and Teamwork	3) Task Management
4) Decision Making	4) Leadership	

คะแนน	การสังเกตการณ์
1	พฤติกรรมการทำงาน ไม่เป็นที่ยอมรับ และมีโอกาสเกิดอันตรายกับผู้ป่วย เป็นพฤติกรรมที่ต้องได้รับการแก้ไข
2	พฤติกรรมการทำงานชี้ให้เห็นถึงสาเหตุที่ ต้องเฝ้าระวัง และต้องได้รับการพัฒนา
3	พฤติกรรมการทำงานที่อยู่ ระดับมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ
4	พฤติกรรมการทำงานที่อยู่ เหนือระดับมาตรฐาน ส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ป่วย และเป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้อื่น
N/R	ทักษะนี้ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ เพราะไม่มีสถานการณ์ในการสังเกตครั้งนี้



Scrub Practitioners' List of Intraoperative Non-Technical Skills (SPLINTS)

Structuring observation, rating and feedback of scrub practitioners' behaviours in the operating theatre

Scrub practitioners' intraoperative non-technical skills (SPINTS),



1) การตระหนักถึงสถานการณ์ที่เป็นปัญหา (Situation awareness)

1.1) การรับรู้ข้อมูล (Gathering information)

1.2) ยอมรับ และทำความเข้าใจกับข้อมูล (Recognizing and understanding information)

1.3) การคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต (Anticipating)

2) การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม (Communication and teamwork)

2.1) การสื่อสารเพื่อยืนยันในสิ่งที่ถูกต้อง (Acting assertively)

2.2) การแลกเปลี่ยนข้อมูล (Exchanging information)

2.3) การร่วมงานกับผู้อื่น (Coordinating with others)

3) การบริหารจัดการงานที่สำคัญ (task management)

3.1) การวางแผนและเตรียมการ (Planning and preparing)

3.2) การปฏิบัติตาม และรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Providing and maintaining standards)

3.3) การเผชิญกับภาวะกดดัน (Coping with pressure)

SPINTS		Good behavioral marker	Poor behavioral markers
1) การตระหนักถึงสถานการณ์ที่เป็นปัญหา (Situation awareness)			
1.1) การรวบรวมข้อมูล	- ดูการผ่าตัดอย่างตั้งใจ	- ทำงานอยู่อย่างเดียว	
	- เก็บข้อมูลจากทีมผ่าตัด	- ไม่ฟังข้อมูลจากทีมผ่าตัด	
1.2) ตระหนัก และทำความเข้าใจกับข้อมูล\	- ปรับเปลี่ยนงานอย่างมีประสิทธิภาพ	- ไม่เรียงลำดับความสำคัญของงาน	
1.3) การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	- คาดการณ์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแผนของการผ่าตัด	- ตามการผ่าตัดไม่ทันโดยที่ไม่รู้ตัว เกิดความผิดพลาดในงาน จากการไม่ใส่ใจ ไม่รู้ตัว	
2) การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม (Communication and teamwork)			
2.1) การสื่อสารเพื่อยืนยันในสิ่งที่ถูกต้อง	- สื่อสารในเรื่องที่สำคัญ/ในขั้นตอนสำคัญ	- ไม่สื่อสารเรื่องที่สำคัญ/ในขั้นตอนสำคัญ	
2.2) การแลกเปลี่ยนข้อมูล	- ให้ข้อมูลที่ชัดเจน กระชับ ได้ใจความ	- สื่อสารล่าช้า	
2.3) การทำงานร่วมกับคนอื่น	- สนับสนุนผู้อื่นโดยการช่วยเหลือหรือเป็นผู้ช่วย	- ยอมให้มีการขัดจังหวะ (interruption) ในขั้นตอนการผ่าตัด - ยอมให้เพื่อนมาแทรกขณะปฏิบัติงาน	
3) การบริหารจัดการงานที่สำคัญ (task management)			
3.1) การวางแผนและเตรียมการ	- ใช้เวลาพักระหว่างการผ่าตัดในการเตรียมงานลำดับต่อไป	- การเตรียมงานที่สับสน ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการผ่าตัด	
3.2) การปฏิบัติตาม และรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน	- ปกป้องบริเวณเขตปลอดเชื้อ และเครื่องมือปลอดเชื้อ	- ไม่ยึดมั่นในแนวทาง aseptic & sterile technique	
3.3) การเผชิญกับภาวะกดดัน (Coping with pressure)	- ควบคุมอารมณ์ ไม่ขึ้นเสียงใส่ผู้ที่อารมณ์เสีย	- ขึ้นเสียงดังโดยไม่จำเป็น - พฤติกรรมก้าวร้าว กระแทก/ โยนเครื่องมือผ่าตัด	
	- มอบหมายงานให้ผู้อื่นที่สามารถทำได้ เพื่อลดแรงกดดันในสถานการณ์ที่มีความกดดัน	- หยุตนิ่ง / ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	





ทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคของพยาบาลห้องผ่าตัดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง*

วรสณวิมล กอสุวรรณ, ปส.ด.¹ รัตติมา ศรีโสรชัย, PhD² ธนพวรรณ กุลละศิริ, พย.บ.¹
มนันพิทร์ ทอบุญเกิด, พย.บ.¹ วศัญญุตา เวียรชัย, พย.บ.¹

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคจำแนกรายด้านและร้อยละของพยาบาล
ที่ได้คะแนนต่ำกว่ามาตรฐาน (N = 99)

ทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค	$\bar{X}$	SD	ร้อยละที่คะแนนต่ำกว่ามาตรฐาน
1. การตระหนักถึงสถานการณ์ที่เป็นปัญหา	3.15	.56	12.1
1.1 การรับรู้ข้อมูล	3.39	.56	4.5
1.2 ยอมรับและทำความเข้าใจกับข้อมูล	3.03	.69	23.7
1.3 การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	3.03	.69	21.2
2. การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม	3.05	.53	15.1
2.1 การสื่อสารเพื่อยืนยันในสิ่งที่ถูกต้อง	3.03	.63	17.1
2.2 การแลกเปลี่ยนข้อมูล	3.17	.53	8.5
2.3 การร่วมงานกับผู้อื่น	2.92	.66	19.7
3. การบริหารจัดการงานที่สำคัญ	3.21	.46	14.1
3.1 การวางแผนและเตรียมการ	3.09	.64	22.2
3.2 การปฏิบัติตาม และรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน	3.35	.54	8.6
3.3 การเผชิญกับภาวะกดดัน	3.19	.63	11.6
โดยรวม	3.13	.48	15.2

ตารางที่ 3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง อายุ ประสบการณ์การทำงานกับทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค ในพยาบาล
ส่งเครื่องมือผ่าตัด

ตัวแปรที่ศึกษา	1	2	3	4	5	6
1. อายุ	1					
2. ประสบการณ์การทำงาน	.740**	1				
ทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค						
3. ด้านการตระหนักถึงสถานการณ์ที่เป็นปัญหา	.279**	.407**	1			
4. ด้านการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม	.247**	.379**	.819**	1		
5. ด้านการบริหารจัดการงานที่สำคัญ	.183*	.257**	.752**	.760**	1	
6. โดยรวม	.263**	.386**	.940**	.932**	.894**	1

* $p < .05$ **

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิครายด้านและโดยรวม จำแนกตามประเภทของการผ่าตัด

ประเภทการผ่าตัด (จำนวน)	ทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค							
	ตระหนักถึงสถานการณ์ที่เป็นปัญหา		การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม		การบริหารจัดการงานที่สำคัญ		โดยรวม	
	$\bar{X}$ (SD)	F (p)	$\bar{X}$ (SD)	F (p)	$\bar{X}$ (SD)	F (p)	$\bar{X}$ (SD)	F (p)
พื้นฐาน (26)	3.03 (.60)		2.95 (.58)		3.25 (.52)		3.07 (.53)	
ยุ่งยากซับซ้อนปานกลาง (50)	3.11 (.54)	2.763 (.068)	2.99 (.05)	3.034 (.053)	3.07 (.42)	5.787 (.004)	3.06 (.44)	3.609 (.037)
ยุ่งยากซับซ้อนมาก (23)	3.38 (.50)		3.38 (.50)		3.44 (.40)		3.36 (.43)	

ข้อสังเกต* คือ Incident เกิดขึ้นได้ในการผ่าตัดทุกประเภท

A Delphi study identifying operating room nurses' non-technical skills

Irene Sirevåg  | Ingrid Tjøflåt  | Britt Sætre Hansen 

Abstract

Aim: To identify the non-technical skills of operating room nurses. This is the first empirical study that includes scrub and circulating operating room nurses.

Design: A three-round modified online Delphi technique was used for this study.

Methods: Eligible participants ($n = 106$) with a minimum of 2 years of operating room nursing experience were selected for the expert panel by self-recruitment from a population ($N = 1640$) of operating room nurses. Data were collected through online surveys, based on crew resource management theory, between April and September 2020. Descriptive statistics analysis was used for the quantitative data, and deductive

Situation Awareness, Communication and Teamwork,
decision-making, Leadership

Conclusion: The non-technical skills of operating room nurses are more extensive than previously identified. This study has contributed to a verbalization of the tacit knowledge and skills of the operating room nurses. In addition, a list of non-technical skills that should be included in the education of operating room nurses to ensure patient safety in the operating room has been prepared.

Impact: This study addresses the lack of research on the non-technical skills of operating room nurses. When exploring the non-technical skills of scrub and circulating nurses, a diversity of novel non-technical skills was uncovered. This research will provide input for the development of a new training, supervision and assessment tool for accelerated development of the non-technical skills of operating room nurses. This contribution to the verbalization of the formerly tacit non-technical skills may facilitate clinical and formal teaching of such skills and may subsequently impact surgery-related patient safety.

Update
2021



Nontechnical skills of the operating theatre circulating nurse: An ethnographic study

Maria Redaelli 

Perioperative Care and Operating Room Management 23 (2021) 100167



Contents lists available at ScienceDirect

Perioperative Care and Operating Room Management

journal homepage: www.elsevier.com/locate/pcom

Development and psychometric evaluation of a behavioral marker system for circulating nurse's non-technical skills

Reza Kalantari ^a, Zahra Zamanian ^{a,*}, Mehdi Hasanshahi ^b, Jamshid Jamali ^c, Ali Akbar Faghihi ^d, Hadi Niakan ^e, Javad Abbasi ^f

4) การตัดสินใจ และภาวะผู้นำ (decision making and leadership)

4.1) การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและการจัดการ (Prioritization)

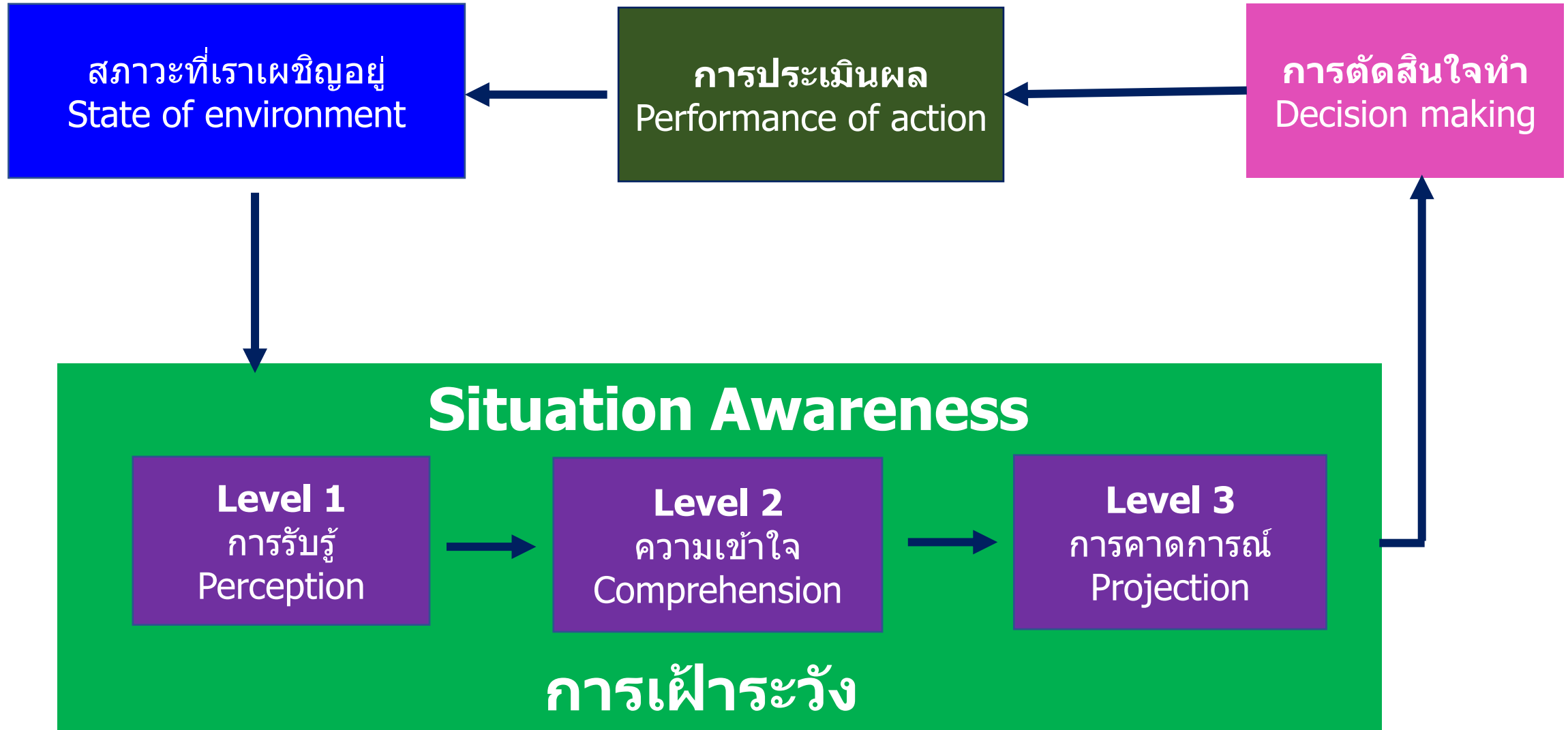
4.2) จูงใจผู้อื่นให้ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย (Negotiation)

4.3) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuing learning)

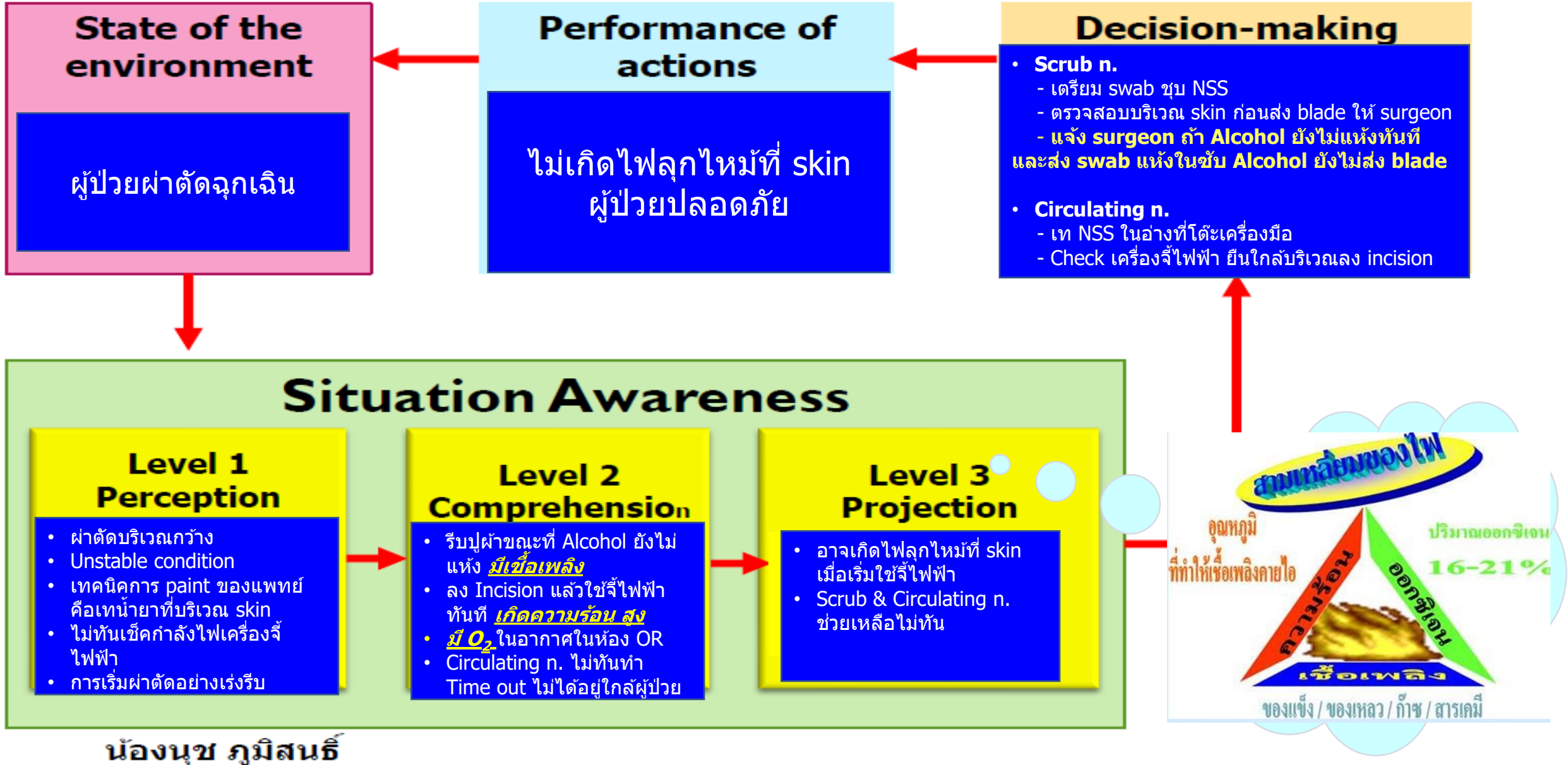
Situation Awareness คืออะไร ?



1) Situation Awareness



Situation awareness : Patient Safety



คนที่ม่ situation awareness ต่างจาก
คนที่ม่กั้วล พวกวตทกจรต พวทยะะ อย่งไร?

	คนที่ม่ situation awareness	คนที่ม่กั้วล
การรับรู้ (Perception)	รับรู้ข้อมูลจริง ท้งหมดครบทุกด้าน	รับรู้ข้อมูลแบบจริงและม่จริง ม่ครบ
ความเข้าใจ (Comprehension)	คตวิเคราะห์ข่งเหตุผล ม่ใช้ความเคยชิน	เข้าใจสถานการณ์แบบใช้ความเคยชิน
คาคการณ์ (Projection)	คาคการณ์ส่เงที่จะเกดข่งขึ้น ข่งสอตคล้งกับ ข้อมูลที่มีอยู่จริง	คาคการณ์ส่เงที่จะเกดข่งขึ้น สอตคล้งกับข้อมูลที่มี อยู่จริงเพ่ียงบางส่วน หร่ม่สอตคล้งเลย
การตัดสินใจ (Decision Making)	มีการวางแผน เพื่การตัดสินใจป้งกัน ม่ให้ เกด	ม่มีการวางแผน วอยวายไว้กอน และม่ ตัดสินใจ หร่ม่ตัดสินใจผด
ผลลัพธ์ (Action performance)	ไ้รับความไว้วางใจ น่าเช่ือถื่อ เป็นแบบอย่งที่ ดี "ทักแล้วมีคณฟ้ง"	ม่น่าไว้วางใจ ถูกกล่าวหาว่าเป็น "พว ยะะ, พวกป้า"

2) Effective Communication & Teamwork



Speak up

ขอทำ
Time out

Specimen
คือ..

เข็มหาย
swab ไม่ครบ

Call for help

ยาที่ให้คือ
....

ขอ 5 นาที
นับ swab

Critical
concern
คือ

ไม่แน่ใจ ทำแบบ
นี้ถูกไหม ??

ไม่เคยเห็น
ไม่เคยทำ ??

ช่วยตรวจให้
หน่อย ??



การสื่อสารเพื่อผู้ป่วยปลอดภัย



วัตถุประสงค์หลัก

1. การสื่อสารเพื่อการเฝ้าระวังผู้ป่วย (monitoring) เช่น

- ก่อนผ่าตัด เช่น ประเมินแล้วพบความเสี่ยง, Time out, Surgical Safety Checklist, Briefing
- ขณะผ่าตัด เช่น เกิด bleeding, เครื่องมือยังไม่พร้อม, Contaminate
- หลังผ่าตัด เช่น พบภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

2. การสื่อสารเพื่อการประสานความร่วมมือ (coordination of care) เช่น

- ติดต่อขอยาด่วน, เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย, ส่งตรวจ frozen section

3. การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการดูแลอย่างต่อเนื่อง (maintaining continuity of care during care transition) เช่น

- การส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เมื่อจะรับ-ส่งผู้ป่วย, Sign out, Hand off
- ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวกับผู้ป่วยและญาติ
- การเยี่ยมผู้ป่วยก่อน/หลังผ่าตัด

Table 1. Standard Bundle to Prevent Unintentional Retained Surgical Items and Foreign Objects Consisting of Five Standard Elements and One Recommended Element

Standard Bundle Element	Definition
Surgical STOP	<u>Surgical STOP</u> ต้องเริ่มโดยศัลยแพทย์ก่อนการเย็บปิดแผลครั้งแรก โดยศัลยแพทย์จะประกาศว่า “ถึงเวลาสำหรับ Surgical STOP” ทุกคนในทีมต้องหยุดกิจกรรมทั้งหมด ในขณะที่ศัลยแพทย์ทำการตรวจสอบสำรวจบาดแผล ศัลยแพทย์สรุปโดยประกาศว่า “ตรวจบาดแผลเรียบร้อยแล้ว” หากศัลยแพทย์ไม่เป็นผู้เริ่ม สมาชิกทีมคนอื่นสามารถเริ่ม Surgical STOP ได้ โดยใช้หลัก <u>ARCC (Ask, Request, voice a Concern, Chain of Command)</u> เช่นพูดว่า “ขอทำ Surgical STOP ก่อนดำเนินการปิดแผลต่อ”
Surgical Debrief /Sign out	A quick debrief is to occur prior to the surgeon leaving the room. All team members are to stop the activity and participate in the debrief. Elements of the debrief are as follows: registered nurse (RN)—verification of all counts, incorrect counts resolution; surgeon—procedure, wound class, estimated blood loss, specimens labeling, medications administered; team—what went well, what can be better, patient disposition (catheter/tubes/drains), additional concerns, and family location.
Visual Counter	A whiteboard is used to track surgical items, including sponges, laps, gauze, needles, and instruments, throughout the invasive/surgical procedure. It should also include standard elements such as patient identifiers and procedure details.
Imaging	Use imaging technology (X-ray or computed tomography, at the discretion of the surgeon) prior to the first stitch of closure when the soft surgical count or needle count (size 7.0 or larger) is incorrect and cannot be resolved (i.e., lost on the field) to validate no items are retained in the patient.
Reporting	Incorrect surgical counts without resolution and failure to initiate or use of ARCC by a team member to initiate the Surgical STOP are to be reported in the event reporting system.
Counter Bags (<i>Recommended Element</i>)	Utilizing a counter bag in the surgical count process is recommended for easier visualization of sponges and to assist with the count process.

Carmack A, Valleru J, Randall K, Baka D, Angarano J, Fogel R. A Multicenter Collaborative Effort to Reduce Preventable Patient Harm Due to Retained Surgical Items. *Jt Comm J Qual Patient Saf.* 2023 Jan;49(1):3-13. doi: 10.1016/j.jcjq.2022.09.005. Epub 2022 Sep 30. PMID: 36334991.

Result: 70.5% Compliance to RSI bundle 14.3% reduction in the rate of harm coursed by RSIs
59.1% increase in RSI near miss reporting

"Speak Up for Safety – Every Voice Matters"



พบความเสี่ยงต่อผู้ป่วย

● **ASK (ถาม)**

"ขอสอบถามค่ะ swab ไม่ครบมี packing ที่ไหนไหมคะ"

↓
ปัญหายังไม่ชัดเจน / ยังไม่แก้ไข

● **REQUEST (ขอให้ดำเนินการ)**

"ขอทำการ Fluoroscopy ค่ะ"

↓
ยังมีความเสี่ยง

● voice of **CONCERN (แสดงความกังวล)**

"ถ้าไม่ flu. ดิฉันกังวลว่าอาจกระทบความปลอดภัยผู้ป่วย"

↓
ยังไม่ได้รับการแก้ไข

● **CHAIN OF COMMAND**

แจ้งหัวหน้าทีม / Supervisor / หยุดกระบวนการ

STOP THE LINE (Critical Safety Action)

หลัก ARCC

เป็นเครื่องมือสำคัญด้าน **communication for patient safety** ที่ช่วยให้บุคลากรสามารถ "กล้าพูด" และ "สื่อสารอย่างเป็นระบบ" เมื่อพบความเสี่ยงต่อผู้ป่วย โดยเฉพาะในบริบทที่มีลำดับชั้น (hierarchy) สูง เช่น ห้องผ่าตัด

Key Success Factors (ทำให้ ARCC ได้ผลจริง)

- ✓ ผู้นำทีมเปิดรับ (Psychological Safety)
- ✓ ไม่มีการลงโทษเมื่อ Speak up (Just Culture)
- ✓ ใช้คำพูดมาตรฐานเดียวกันทั้งทีม
- ✓ ฝึก simulation / role play ใน OR



RESEARCH ARTICLE



Communication as a non-technical skill in the operating room: A qualitative study

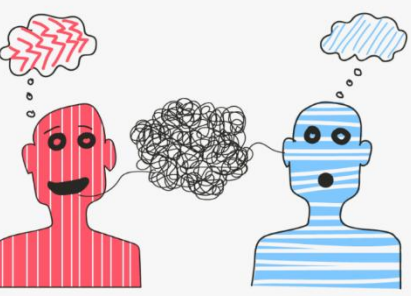
Sisilie Havnås Skråmm¹ | Inger Lise Smith Jacobsen¹ | Ingrid Hanssen²

¹Akershus university hospital, Lorenskog, Norway

²Lovisenberg Diaconal University College, Oslo, Norway

Correspondence
Skråmm Sisilie Havnås, Akershus university hospital, Lorenskog, Norway.
Email: sskr@ahus.no

Funding information
The project this article is based on received financial support from the fund for collaborative activities between clinical nursing practice and an educational institution



Abstract

Aim: The aim of this study was to explore how operating room nurses (ORNs) experience operating room (OR) team communication concerning non-technical skills.

Design: Based on the Scrub Practitioners List of Intraoperative Non-Technical Skill (SPLINTS), qualitative individual in-depth semi-structured interviews were conducted with 11 ORNs in a Norwegian university hospital. Braun and Clarke's six analytic phases for thematic data analysis were used.

Results: Surgeons being unprepared or demanding different instruments than the preoperative information indicates, cause stress and frustration. So does noise and brusquely or poor communication. Ensuring good information flow within the entire team is important. When silence is required, the ORNs communicate with gestures, looks and nods. Creating a positive and secure team culture facilitates discussions, questions and information sharing.

Conclusion: Inappropriate dynamics, inaccurate and/or disrespectful communication and noise may reduce patient safety. Interdisciplinary team training may bring attention to the value of communication as a non-technical skill.

KEYWORDS

communication, Non-technical skills, operating room nursing, patient safety, teamwork

วัตถุประสงค์

การสำรวจประสบการณ์ของพยาบาลห้องผ่าตัดเกี่ยวกับการสื่อสารของทีมในห้องผ่าตัด

การออกแบบ

การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างเป็นรายบุคคล โดยใช้รายการทักษะที่ไม่ใช่ด้านเทคนิคระหว่างการผ่าตัดของผู้ปฏิบัติงาน (SPLINTS) กับ ORNs จำนวน 11 คนในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในนอร์เวย์

ใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลตามหัวข้อหกขั้นตอนของ Braun และ Clarke

ผลการศึกษา

- ศัลยแพทย์ที่เตรียมตัวไม่พร้อมหรือขอเครื่องมือที่แตกต่างจากข้อมูลก่อนการผ่าตัดทำให้เกิดความเครียดและความหงุดหงิด
- เสียงรบกวนและการสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำที่หยาบหรือไม่ดี ทำให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ
- ห้องผ่าตัดจำเป็นต้องเงียบ เพื่อให้ทุกคนภายในทีมผ่าตัดได้รับฟังข้อมูลเหมือนกัน และครบถ้วนเป็นสิ่งสำคัญ
- **ORNs สื่อสารด้วยท่าทาง การมอง และการพยักหน้าร่วมด้วย**
- การสร้างวัฒนธรรมทีมที่เป็นบวกและปลอดภัย ส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูล การตั้งคำถาม และการอภิปราย

สรุป

- ❖ การมีพลวัตที่ไม่เหมาะสม การสื่อสารที่ไม่ถูกต้องและ/หรือไม่ให้เกียรติ และเสียงรบกวนอาจลดความปลอดภัยของผู้ป่วยได้
- ❖ การฝึกอบรมทีมสหสาขาวิชาชีพสามารถทำให้เห็นความสำคัญของการสื่อสาร ซึ่งเป็นทักษะที่ไม่ใช่ด้านเทคนิคที่สำคัญ



Assertive Communication



Assertiveness is HARD

- Honest สิ่งที่จะพูดเพื่อผู้ป่วยปลอดภัย
- Appropriate จังหวะที่จะพูด
- Respectful น่าเสียงท่าที ให้เกียรติกัน
- Direct way เนื้อหาที่ตรงประเด็น

เนื้อหาที่ตรงประเด็น จังหวะที่พูด น่าเสียงท่าที
ต้องฝึกฝน**

Communicating assertively will not
guarantee the
other person will change
his or her behavior and
give you what you want,
but it will help you
establish limits and
boundaries with others.

Assertiveness Is Simple but Hard

NonAssertive (Passive)

- ☹️ H onest
- ✓ A ppropriate
- ✓ R espectful
- ☹️ D irect

Assertive (Tactful)

- ✓ H onest
- ✓ A ppropriate
- ✓ R espectful
- ✓ D irect

Aggressive (Rude)

- ✓ H onest
- ☹️ A ppropriate
- ☹️ R espectful
- ✓ D irect

Assertive Communication



- ดึงความสนใจ (Get attention)
- แนะนำตัว
- พูดถึงความเป็นจริงที่เรารับรู้ ที่เรากังวล หรือแกล้งโง่
- เสนอแนวทางเลือก
- รับฟังข้อคิดเห็น
- หากเป็นไปได้ให้ทำโดยไม่มีบุคคลที่ 3
- หาตัวช่วย



Teamwork



คุณลักษณะที่ดี ของการทำงานเป็นทีม (Teamwork)

1. **Share mental model**: การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล และความรู้ของบุคลากรในทีม ซึ่งส่งผลต่อการเข้าใจใน บทบาทหน้าที่ ของกัน และกัน
2. **Coordination**: การประสานงานกันในทีม เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีที่สุด
3. **Cooperation**: การทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทีม



3) Task management



3.1) การวางแผนและเตรียมการ (Planning and preparing)

3.2) การปฏิบัติตาม และรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Providing and maintaining standards)

3.3) การเผชิญกับภาวะกดดัน (Coping with pressure)

เครียด



เสีย
ใจ



เราท้อ..



เพลีย



อย่าเครียด



เราต้องสู้!



เวลาเราเครียด
อย่าเพิ่งกินพารา
ให้ลองนินทาชาวบ้านดู
ก่อน





Workplace Violence ??

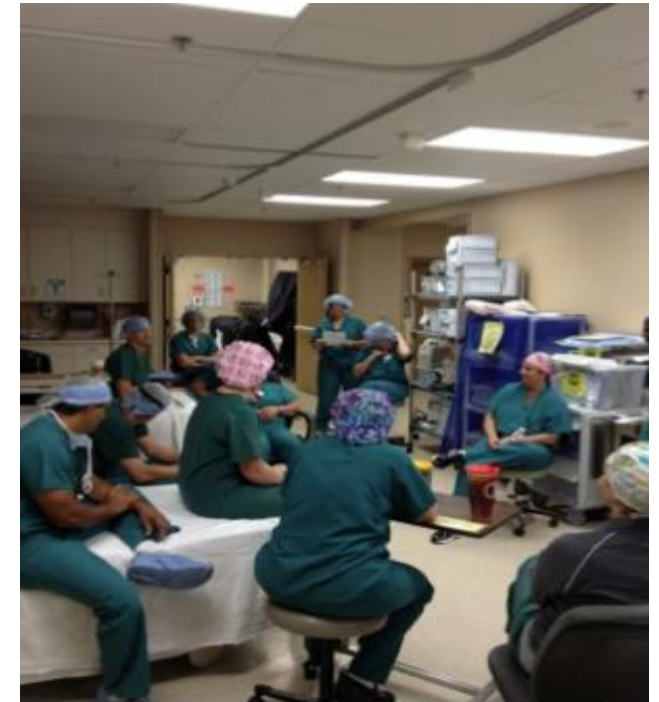
อย่า ระบายออกทาง Social media เด็ดขาด!!!

Mental Health and Mediation



1) Mindfulness at work

- Meditation before start work
- Communication
 - Briefing before surgery
- Case / Content Conference
 - ward meeting
 - Journal club



2) Zero Second Victim

- First victim: ผู้ป่วย เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง
- **Second victim** : บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
- Third victim : องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

common second victim physical symptom

- นอนไม่หลับ ความดันขึ้น ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน
ระบบทางเดินอาหารไม่ปกติ

common second victim psychosocial symptom

- วิตกกังวล ไม่กล้าตัดสินใจ ขาดความมั่นใจ กลัวต่อการรักษา
 - ออกจากวิชาชีพ
- ** มีอาการมากกว่า 2 สัปดาห์ ต้องเข้าช่วยเหลือ****





Second Victim Prevention

- No blame, No shame culture
- Emotional first aid
- Monitoring second victim phenomenon
- Consultant



Stress Management

- Employer Assistance Program
- Work – life balance
- Happy workplace



4.1)การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและการจัดการ (Prioritization)

- ## 4.2) จูงใจผู้อื่นให้ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย (Negotiation)

- ### 4.3) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuing learning)

-
- A cartoon illustration of a surgical suite. In the center, a patient lies on a table covered with a green drape. Several staff members in blue scrubs and surgical masks are present. One staff member is kneeling on the left, cleaning a spill of red liquid. Another staff member is standing on the right, holding a tray. A red circle highlights a staff member's feet, which are wearing green shoes. The background shows shelves with various items, including a bottle labeled 'ACEBON'. The cartoon is signed 'AORN' in the bottom left corner.

ทำอะไรก่อน ?

เปิดเครื่องจี้ไฟฟ้า

safety
alarms



ขาน Time out



ทำอะไรให้บุคลากรมี
Non technical skills
ควบคู่ไปกับ Technical
skills ?



การพัฒนา Non Technical skills งานการพยาบาลผ่าตัด โรงพยาบาลศิริราช



การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ระดับบุคคล

- 1) Education & Training บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
 - บรรยายทฤษฎี มโนทัศน์ของ NTS
 - workshop วิเคราะห์สถานการณ์
 - Simulation , Role play
- 2) กำหนด **NTS** ในการประเมิน Specific Functional Competency ของบุคลากร
- 3) **Multidisciplinary training → IPE**

Comprehensive test



© AORN, Inc. 2009

AORN

Kent Jones

"Doctor, please": Educating Nurses to Speak Up With Interactive Digital Simulation Tablets[☆]

Bracq, M.-S., Michinov, E., Duff, M.L., & Jannin, P. (2021, Month). "Doctor, please": Educating Nurses to Speak Up With Interactive Digital Simulation Tablets. *Clinical Simulation in Nursing*, 54, 97-104. <https://doi.org/10.1016/j.ecns.2021.01.007>.



Figure 1 Photo of the virtual reality environment on tablet.

Scenario of Simulation

- 1: Circulating nurse สวมต่างหู
- 2: Circulating nurse เข้ามาใกล้โต๊ะเครื่องมือมากเกินไป
- 3: ศัลยแพทย์ไม่ได้สวมหน้ากากอย่างถูกต้อง
- 4: ศัลยแพทย์จากห้องผ่าตัดอื่นที่สวมชุดเปื้อนเข้ามาในห้องผ่าตัดเพื่อพบเพื่อนร่วมงานและเข้าใกล้เขตปลอดเชื้อมากเกินไป

การประเมินผล

- **Likelihood of speaking up** : จะชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดหรือไม่? (1-7 point)
- **Feelings of embarrassment** : รู้สึกอายแค่ไหนที่จะทำเช่นนั้น? (1-7 point)
- **Strategies for speaking up** : จะทำอย่างไร? (write down & Coding)

ผลการศึกษา

1) **Likelihood of speaking up** แตกต่างกันตามสถานการณ์ทางคลินิกมากกว่าตามสถานะ

2) **Feelings of embarrassment** มีมากกว่าเมื่อพูดกับสถานะทางวิชาชีพสูงกว่า

3) **Strategies for speaking up**

- การเตือนเกี่ยวกับกฎ (55.30%) คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะ (28.03%), การเตือน (23.48%) การใช้อารมณ์ขัน (5.30%)
- Speak up กับศัลยแพทย์เป็นทางการ (72.73%) และมีการระบุชื่อบุคคล (36.36%)
- Speak up กับพยาบาลมักไม่เป็นทางการ (66.67%) และแทบไม่มีการระบุชื่อบุคคล (4.55%)
- ถ้อยคำสุภาพ (26.52%) โดยใช้กับศัลยแพทย์มากกว่าใช้กับพยาบาลเล็กน้อย (30.30% เทียบกับ 22.73%)

Conclusion

- ❖ พยาบาลจะ Speak up ตามการประเมินสถานการณ์ (ลักษณะและระดับความเสี่ยง) มากกว่าตามสถานะของบุคคลที่ถูกพูดถึง
- ❖ รู้สึกอายมากขึ้นเมื่อพูดขึ้นกับบุคคลที่มีสถานะสูงกว่า
- ❖ การเลือกใช้คำและกลยุทธ์เมื่อพูดกับศัลยแพทย์ มากกว่าพูดกับพยาบาล



Specific Functional Competency: งานการพยาบาลผ่าตัด

1. ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลใน บทบาทของพยาบาลส่งเครื่องมือผ่าตัด

คำจำกัดความ: การมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติการพยาบาล ส่งเครื่องมือผ่าตัด เพื่อให้การผ่าตัดดำเนินไปอย่างสำเร็จ โดยผู้ป่วยและบุคลากรปลอดภัย ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เหมาะสมได้

ระดับ ความสามารถ	พฤติกรรมบ่งชี้
Level 1	- ปฏิบัติตาม WI เช่น การนับผ้าซับโลหิตและเครื่องมือผ่าตัด, การล้างมือ ใส่เสื้อ ใส่ถุงมือเพื่อการผ่าตัด เป็นต้น และหลัก Aseptic technique & Sterile technique ได้ เช่น การป้องกันบาดเจ็บจากของมีคม, การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในห้องผ่าตัด เป็นต้น - จัดเตรียม ส่งเครื่องมือผ่าตัด และจัดการเครื่องมือหลังผ่าตัดพื้นฐานภายใต้การดูแลของพยาบาลพี่เลี้ยงได้ - ปกป้องบริเวณเขตปลอดเชื้อและเครื่องมือปลอดเชื้อตลอดการผ่าตัด - ดูการผ่าตัด และฟังข้อมูลจากทีมผ่าตัดอย่างตั้งใจ - ขอความช่วยเหลือกับผู้อื่น (Call for help) เมื่อประสบปัญหา หรือไม่มั่นใจขณะส่งเครื่องมือผ่าตัด
Level 2	- อธิบายพยาธิสรีรภาพ อาการ ขั้นตอนการผ่าตัด <u>พื้นฐาน</u> และ <u>ความเสี่ยงทางคลินิกที่สำคัญ (Specific Clinical risk)</u> ได้ - จัดเตรียมเครื่องมือ ยาและสารน้ำที่ใช้ในการผ่าตัด และส่งเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานได้ด้วยตัวเอง - ปฏิบัติการพยาบาลระยะขณะผ่าตัดถูกต้องตามมาตรฐานการพยาบาล - ให้ข้อมูลที่ชัดเจน กระชับได้ใจความกับทีมผ่าตัดในขั้นตอนสำคัญ เช่น ขณะส่งของมีคม และยา ผ้าซับโลหิตไม่ครบ เป็นต้น - เผชิญกับความเครียดได้ โดยควบคุมอารมณ์ ไม่แสดงกิริยาไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม
Level 3	- อธิบายพยาธิสรีรภาพ อาการ และขั้นตอนการผ่าตัดที่ <u>ยุ่งยากซับซ้อน</u> และ <u>ความเสี่ยงทางคลินิกที่สำคัญ (Specific Clinical risk)</u> ได้ - จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยา และส่งเครื่องมือผ่าตัดที่ยุ่งยาก ซับซ้อนภายใต้การดูแลของพยาบาลพี่เลี้ยงได้ - แจ้งทีมแพทย์ พยาบาลทันที (Speak up) เมื่อพบว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยง เช่น ยังไม่มีการขาน Time out, เครื่องมือผ่าตัดปนเปื้อน เป็นต้น - ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม - แสดงความต้องการเครื่องมือ อุปกรณ์เพิ่มเติมในจังหวะเวลาที่เหมาะสมกับงานที่ทำ

Specific Functional Competency : งานการพยาบาลผ่าตัด

1. ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลใน บทบาทของพยาบาลส่งเครื่องมือผ่าตัด (Scrub nurse)
 คำจำกัดความ: การมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติการพยาบาล ส่งเครื่องมือผ่าตัด เพื่อให้การผ่าตัดดำเนินไปอย่างสำเร็จ โดยผู้ป่วยและบุคลากรปลอดภัย ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เหมาะสมได้

ระดับ ความสามารถ	พฤติกรรมบ่งชี้
Level 4	1. ปฏิบัติการพยาบาลระยะขณะผ่าตัดถูกต้องตามมาตรฐานการพยาบาลภายใต้สถานการณ์การผ่าตัดที่ซับซ้อน/ วิกฤตได้ 2. วางแผน และจัดเตรียมงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ ยา และส่งเครื่องมือผ่าตัดที่ยุงยาก ซับซ้อนได้ด้วยตัวเอง 3. กำกับ ดูแล และนิเทศพยาบาลรุ่นน้องในการส่งผ่าตัดได้ 4. เรียงลำดับความสำคัญ (รุนแรง เร่งด่วน) ของปัญหา ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และสมเหตุสมผล เช่น Bleeding, Perforation, Obstruction, Contamination, ผ้าซับโลหิตไม่ครบ เป็นต้น รวมทั้งเสนอทางเลือก/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับทีมผ่าตัด 5. ติดตาม วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อพัฒนาดตนเองให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นต้นแบบที่ดี
Level 5	1. คาดการณ์ความเสี่ยง และวางแผนจัดการเพื่อป้องกันความเสี่ยง/แก้ไขปัญหาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของการผ่าตัดได้ 2. เป็นที่ปรึกษา มอบหมายงานให้ผู้อื่นที่สามารถทำได้ เพื่อลดแรงกดดันในสถานการณ์ที่มีความเครียดสูง 3. ให้คำแนะนำทีมผ่าตัด และบุคลากรอื่นๆ อาทิ แพทย์ฝึกหัด นักศึกษา ผู้เยี่ยมชมงาน เมื่อเห็นเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยและบุคลากร 4. นำความรู้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อมูลมาวิเคราะห์ประเด็นการสร้างงานพัฒนาคุณภาพ สร้างองค์ความรู้ใหม่ เช่น คู่มือ, Guideline, นวัตกรรมต่างๆ เป็นต้น 5. เป็นผู้เผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น วิทยากร, Preceptor หลักสูตรหลังปริญญา, นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการต่างๆ เป็นต้น



2. ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลในบทบาทของ พยาบาลช่วยเหลือรอบนอก (Circulating nurse)

คำจำกัดความ: การมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติการพยาบาลในการช่วยเหลือรอบนอก

ระดับ ความสามารถ	พฤติกรรมบ่งชี้
Level 1	1.สามารถปฏิบัติตาม WI เช่น การทำความสะอาดห้องผ่าตัด , การเตรียมความพร้อมอุปกรณ์พื้นฐานในห้องผ่าตัด ได้แก่ เตียง , suction , การนับผ้าซับโลหิต , การนับเครื่องมือ , การนับสิ่งมีคม 2.สามารถปฏิบัติตามหลัก Aseptic technique & Sterile technique ได้ เช่น การเปิดห่อของปลอดเชื้อ , ช่วยใส่เสื้อให้แพทย์ 3.สามารถอธิบายและจัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดทำผู้ป่วยชั้นพื้นฐานได้ 4. ติดตาม สังเกตขั้นตอนการผ่าตัดอย่างจริงจัง 5. สื่อสารกับพยาบาลรณี/ ทีมผ่าตัดทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 6. บันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่จำเป็นครบถ้วนด้วยลายมือที่อ่านง่าย
Level 2	1.สามารถอธิบายพยาธิสรีรภาพ อาการ และวิธีการผ่าตัดชั้นพื้นฐานได้ 2.สามารถช่วยแพทย์ในการจัดทำผ่าตัด ภายใต้การดูแลของพยาบาลพี่เลี้ยงได้ 3.ให้การพยาบาลผู้ป่วยขณะผ่าตัดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเบื้องต้น เช่น Hypothermia , อันตรายจากการใช้น้ำยาหรือสารเคมีต่างๆ เป็นต้น 4.สามารถทำ Surgical safety checklist ได้ 5. แจ้งทีมแพทย์ทันที เมื่อพบว่าผู้ป่วยเริ่มมีอาการเปลี่ยนแปลงที่อาจไม่ปลอดภัย 6. แสดงออกอย่างเหมาะสม/ ควบคุมอารมณ์เมื่อถูกตำหนิ โดยไม่ให้กระทบงานที่ทำอยู่ 7. ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยที่จำเป็นเพื่อการดูแลต่อเนื่องได้ครบถ้วน กระชับ ชัดเจน
Level 3	1.สามารถอธิบายพยาธิสรีรภาพ อาการ และวิธีการผ่าตัดที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ 2.สามารถจัดทำในการทำผ่าตัดที่ยุ่งยากได้ 3.ให้การพยาบาลผู้ป่วยขณะผ่าตัดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่ซับซ้อนได้ เช่น Nerve injury , Deep vein thrombosis 4.สามารถติดต่อประสานงานและส่งต่อข้อมูลภายในหน่วยงานได้ 5.สามารถควบคุมดูแลให้พยาบาลรณีน้อง ส่งผ่าตัดในการผ่าตัดพื้นฐานได้ 6.สามารถดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลตามแผนการรักษาเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การให้ยา Antibioticตามแผนการรักษา 7. จัดลำดับความสำคัญของงาน โดยคำนึงเรื่องความปลอดภัยผู้ป่วยเป็นสำคัญ 8. เตรียมห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ผ่าตัดให้พร้อมเมื่อทราบว่าจะมีผู้ป่วยฉุกเฉินต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วน



2. ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลในบทบาทของพยาบาลช่วยเหลือรอบนอก (Circulating nurse)

คำจำกัดความ: การมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติการพยาบาลในการช่วยเหลือรอบนอก

ระดับ ความสามารถ	พฤติกรรมบ่งชี้
Level 4	1.สามารถจัดทำในการทำผ่าตัดที่ยุงยากซับซ้อนได้ 2.สามารถคาดการณ์และวางแผนให้การพยาบาลผู้ป่วยขณะผ่าตัดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่ซับซ้อนได้ 3.สามารถติดต่อประสานงานและส่งต่อข้อมูลภายนอกหน่วยงานได้ 4.สามารถควบคุมกำกับดูแลให้พยาบาลรุ่นน้อง ส่งผ่าตัดในการทำผ่าตัดที่ยุงยากซับซ้อนได้ 5.สามารถดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาตามแผนการรักษาที่ยุงยากอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การบริหารยา High Alert Drug 6. ให้ความช่วยเหลือทีมศัลยแพทย์ ทีมวิสัญญี เมื่อทีมเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ภาวะเลือดออกมาก การใส่ท่อช่วยหายใจยาก เป็นต้น 7. เรียงลำดับความสำคัญ (รุนแรง เร่งด่วน) ของปัญหา ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และสมเหตุสมผล
Level 5	1.สามารถบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยขณะผ่าตัด สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น เช่น การนำหลักฐานเชิงประจักษ์และผลงานวิจัยมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยขณะผ่าตัดได้ เป็นต้น 2.สามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องผ่าตัดได้เช่น ผ่าซับซ้อนโลหิตนับไม่ครบ , เกิดความคลาดเคลื่อนในการส่งส่งตรวจ ฯลฯ 3.สามารถร่วมทำหรือทำวิจัยเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดได้ 4.สามารถเป็นที่ปรึกษาและนิเทศงานเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยขณะผ่าตัด 5. เสนอความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา/ จัดการเหตุการณ์ต่างๆ เชิงระบบอย่างสร้างสรรค์ 6. ให้คำแนะนำทีมผ่าตัด และบุคลากรอื่นๆ อาทิ แพทย์ฝึกหัด นักศึกษา ผู้เยี่ยมชมงาน เมื่อเห็นเหตุการณ์ที่คาดว่าจะอันตรายต่อผู้ป่วยและบุคลากร 7. เรียงลำดับความสำคัญ (รุนแรง เร่งด่วน) ของปัญหา ตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่ยุงยากซับซ้อนได้อย่างทันท่วงที และสมเหตุสมผลทั้งปัญหาทาง Clinic & Non Clinical 8. ติดตาม วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นต้นแบบที่ดี

S-TEAMS: A Truly Multiprofessional Course Focusing on Nontechnical Skills to Improve Patient Safety in the Operating Theater[☆]



Emma Stewart-Parker, MRCS (Eng), MA (Cantab), BM,* Robert Galloway, FCEM, MRCP, BSc, MBBS,[†] and Stella Vig, FRCS (Eng), MCh, MBBCh, BSc

*Department of General Surgery, Croydon University Hospital, Croydon, Surrey, United Kingdom; and

[†]Brighton and Sussex University Hospitals, United Kingdom

Journal of Surgical Education • © 2016 Association of Program Directors in Surgery. Published by Elsevier Inc. All rights reserved. 1931-7204/\$30.00
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jsurg.2016.06.020>

Surgical Team Education and Management in Simulation: S-TEAMS

หลักสูตรฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่ไม่ใช่ด้านเทคนิค (Nontechnical Skills: NTS) ต่อการทำงานร่วมกันในสถานการณ์ที่ซับซ้อน สำหรับทีมสหวิชาชีพในห้องผ่าตัด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย และช่วยลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดทางการแพทย์

รูปแบบการฝึกอบรม

ช่วงเช้า การบรรยาย กรณีศึกษาและโจทย์ให้ทีมเชิงโต้ตอบ

ช่วงบ่าย การฝึกปฏิบัติในจำลองสถานการณ์ในห้องผ่าตัด

- การสื่อสาร
- การตระหนักรู้สถานการณ์
- การใช้เครื่องมือช่วยเตือน เช่น รายการตรวจสอบ
- การสรุปผลอย่างละเอียดกับผู้สังเกตการณ์ทางคลินิกที่มีประสบการณ์

การประเมินผล

- การประเมินตนเอง ร่วมกับรับข้อเสนอแนะทันที
- ติดตามผลหลังจากอบรม 6 เดือน เพื่อประเมินว่าทักษะเหล่านี้ยังคงถูกนำไปใช้ และส่งผลต่อความปลอดภัยอย่างไร

ผลการศึกษา

- ผู้เข้าร่วม 68 คน ทั้งหมดรู้สึกว่าการหลักสูตรมีโครงสร้างชัดเจนและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน
- 95% สถานการณ์จำลองมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางคลินิกอย่างดีหรือยอดเยี่ยม
- 55% มีความมั่นใจในการ "กล้าพูด" ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพิ่มขึ้น
- 97% ของผู้เข้าร่วมยังคงใช้ทักษะนี้ในระยะยาว
- 88% หลักสูตรนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
- 94% หลักสูตรนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยตรง

สรุป

- ❖ ผู้เข้าอบรมมีความต้องการ และความกระตือรือร้นอย่างแท้จริงในการพัฒนา NTS ภายในทีมงานในห้องผ่าตัด
- ❖ S-TEAMS มีรูปแบบที่เรียบง่าย และสามารถทำซ้ำได้มีความครอบคลุมและยั่งยืน
- ❖ ทักษะที่อบรมยังคงถูกนำไปใช้ในระยะยาว เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ป่วย และการทำงานเป็นทีม

การพัฒนา Non Technical skills

งานการพยาบาลผ่าตัด โรงพยาบาลศิริราช



ระดับบุคคล

การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

- 1) Education & Training บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
บรรยายทฤษฎี มโนทัศน์ของ NTS
 - workshop วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง (Scenario)
 - Simulation , Role play
- 2) กำหนด **NTS** ในการประเมิน Specific Functional Competencyบุคลากร
- 3) **Multidisciplinary training** → **IPE**

ระดับองค์กร

การจัดระบบ/นโยบาย/ แนวทางปฏิบัติ

- 1) มีเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างทีมที่ชัดเจน
 - Surgical Safety Checklist, **Briefing**
 - Hand off Dialog, **ISBAR**
- 2) การมอบหมายหน้าที่ตามตำแหน่งงานในขั้นตอนสำคัญ
- 3) สร้างแนวทางปฏิบัติ Early warning sign (Concurrent trigger tool)
- 4) สร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันที่ดี
- 5) สร้าง **Safety Awareness culture**
 - Morning briefing, **Huddle up**
 - Robust Safety reminder หาด้นแบบ

1) เครื่องมือในการสื่อสารภายในทีมและระหว่างทีมที่ชัดเจน



กระบวนการ	Brief แต่ละทีม	Sign in	Brief ทีมใหญ่	Time out	Sign out
ช่วงเวลา	แต่ละทีมดำเนินการ Brief ในทีม และระหว่างทีม - พยาบาล (เอกสารส่วนที่ 3.1 A-B) - Anesthesia team (เอกสารส่วนที่ 3.2 column ซ้าย) - Surgeon team (เอกสารส่วนที่ 3.3)	ผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด - พยาบาล brief กับวิสัญญีฯ และตรวจสอบผู้ป่วย (เอกสารส่วนที่ 3.1 C, เอกสาร 1 column กลาง)	ก่อนเริ่มการผ่าตัด (Surgical resident/ staff กับทีม)	ก่อนลงมิดผู้ป่วย	เริ่มเย็บปิดผิวหนัง/ ก่อนทำการหัตถการเสร็จสิ้น
ผู้รับผิดชอบและหน้าที่			แพทย์ผ่าตัด brief	Circulating nurse	Circulating nurse
หัวข้อ			- นำสรูป (ในลักษณะเล่าตามลำดับขั้นตอน) - ผู้เกี่ยวข้องหยุดฟัง และตอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง 1. แนะนำทีม 2. ผู้ป่วย (Patient ID): ชื่อ-นามสกุล อายุ 3. ชื่อการผ่าตัด 4. ตำแหน่ง ข้าง Mark site OK 5. การจัดท่า (Position) 6. Imaging ถูกต้อง ☐ Yes ☐ No 7. ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 8. ใช้อุปกรณ์พิเศษ ☐ Yes ☐ No 9. ให้ Antibiotic ☐ Yes ☐ No ชื่อ ... Dose ... ครบ Redosing ทุก 10. ต้องส่ง frozen section* ☐ Yes ☐ No 11. Critical steps/concern ที่ต้องการให้ทีมทราบและเตรียมการ (แต่ละทีมระบุ) - ศัลยแพทย์ - วิสัญญีฯ - พยาบาล	- กล่าวนำหัวข้อ check - ผู้เกี่ยวข้องหยุดฟังและตอบ อาจารย์คะ Time out คะ 1. ผู้ป่วย ชื่อ-นามสกุล 2. ชื่อการผ่าตัด 3. ตำแหน่งข้าง ... 4. Patient Identification แพทย์ตอบ • ทำแล้ว • ถ้ายังไม่ได้ทำให้ทำดังนี้ - Check wristband - ดูแฟ้ม - ดู film 5. ให้ antibiotic เรียบร้อยแล้ว (วิสัญญีฯตอบ ถ้าเป็นผู้ให้) 6. เครื่องมือพิเศษพร้อม 7. อวัยวะเทียม พร้อม	- กล่าวนำหัวข้อ check - ผู้เกี่ยวข้องหยุดฟังและตอบ 1. Post-op diagnosis 2. Operation 3. เครื่องมือ ครบ 4. Swab/ Sponge count ครบ 5. สิ่งที่ต้องดูแลหลังผ่าตัดเป็นพิเศษ (ต้องทำ) ที่ RR, ICU, ward -- ศัลยแพทย์ - วิสัญญีฯ - พยาบาล 6. มีส่งชิ้นเนื้อหรือไม่ ถ้ามี - จำนวน ชิ้น - Patho ชื่อ specimen .. - Culture ชื่อ specimen .. - Frozen section

หมายเหตุ – ให้มี Briefing ของแต่ละทีม – ถ้ามีการเปลี่ยนเวร/ เปลี่ยนทีม ให้มี hand off and hand over: พยาบาล (เอกสารส่วนที่ 3.1 D,E) วิสัญญี (เอกสารส่วนที่ 3.2 column ขวา)

* สามารถปรับ/เพิ่มตามความเหมาะสมของบริบทการผ่าตัดในแต่ละภาควิชา

แนวทางการ Brief ทีมย่อย ของแต่ละทีม WI เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยระยะผ่าตัด

ส่วนที่ 3 แนวทางการ Brief ของแต่ละทีม

3.1 Briefing Nurse Team (เอกสาร A-E)

ใน OR

WR-OR

เอกสาร A Brief ในทีมพยาบาล (Scrub nurse และ Circulating nurse)	เอกสาร B การส่งต่อข้อมูลของพยาบาลห้องพักรอดูอาการก่อนผ่าตัดกับพยาบาลห้องผ่าตัด
1. การระบุตัวผู้ป่วยและอวัยวะผ่าตัด ☐ ชื่อ.....นามสกุล.....อายุ..... ☐ การผ่าตัด..... ☐ อวัยวะ/ ตำแหน่ง.....ข้าง..... 2. การจัดทำ ☐ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์จัดทำ อุปกรณ์รองรับอวัยวะต่างๆ ☐ สิ่งที่ต้องระวังในการจัดทำผ่าตัด คือ..... 3. การเตรียมเครื่องมือ/เครื่องมือพิเศษ ☐ ได้จัดเตรียมเครื่องมือผ่าตัด basic/ เครื่องมือพิเศษ ที่วางแผนไว้ ระบุ..... ☐ ได้จัดเตรียมเครื่องมือบริษัท (Loaner instrument) ที่วางแผนไว้ ระบุ..... ☐ เครื่องมือผ่าตัดได้ผ่านการตรวจสอบการคงสภาพปราศจากเชื้อ (Indicator วันหมดอายุ สภาพห่อ/กล่องเครื่องมือ) 4. การเตรียม Implants/ prosthesis ☐ ได้ตรวจสอบชนิด/ ประเภท ขนาดของ Implant/ Prosthesis ที่วางแผนไว้ จากตารางการผ่าตัด/ สอบถามศัลยแพทย์ ☐ ได้ตรวจสอบการคงสภาพปราศจากเชื้อของ Implant/ Prosthesis (Indicator วันหมดอายุ สภาพกล่อง Implant/ Prosthesis)	1. การระบุตัวผู้ป่วยและอวัยวะผ่าตัด (ถามผู้ป่วย) ☐ ชื่อ.....นามสกุล.....อายุ..... (check wristband) ☐ การผ่าตัด..... ☐ อวัยวะ/ ตำแหน่ง.....ข้าง..... (check mark site) 2. ตรวจสอบประวัติแพ้ยา/ อาหาร (ถามผู้ป่วย) ☐ มีประวัติแพ้ยาหรืออาหารหรือไม่ 3. Antibiotic prophylaxis 3.1 กรณีผู้ป่วยมีคำสั่งการรักษาที่จะต้องให้ยา Antibiotic prophylaxis ที่ห้องพักรอดูอาการก่อนผ่าตัด ☐ ผู้ป่วยได้รับยา Antibiotic ชื่อ.....ขนาดยา.....วิธีการให้ยา.....ระบุเวลาที่เริ่มให้ยา..... 3.2 กรณีผู้ป่วยมีคำสั่งการรักษาที่จะต้องให้ยา Antibiotic prophylaxis ในห้องผ่าตัด ☐ ให้นำยา Antibiotic ให้พยาบาลห้องผ่าตัด ☐ แจ้งชื่อยา ขนาด และจำนวนของยา Antibiotic 4. <u>Problem list และความต้องการการดูแลต่อเนื่อง</u> เช่น การ off ยา Aspirin ผู้ป่วยติดเชื้อ ☐ ผู้ป่วยมีปัญหาดังต่อไปนี้ ระบุ..... ☐ สิ่งที่ต้องระวังในการผ่าตัด คือ.....

OR-RR

เอกสาร D

การส่งต่อข้อมูลของพยาบาลห้องผ่าตัดกับพยาบาลห้องพักรฟื้น

- การระบุตัวผู้ป่วยและอวัยวะผ่าตัด
☐ ผู้ป่วยชื่อ.....นามสกุล.....อายุ.....
(พยาบาลห้องพักรฟื้น check wristband)
☐ การผ่าตัด.....
☐ อวัยวะ/ ตำแหน่ง.....ข้าง.....
- ขณะทำผ่าตัด
☐ ไม่พบภาวะแทรกซ้อน
☐ พบภาวะแทรกซ้อน ระบุ.....
- การคืน/ ผ่าเลือก
☐ ไม่มี
☐ การคืน/ ผ่าเลือก ชนิด..... จำนวน.....
- Problem list และการดูแลต่อเนื่อง เช่น การจัดท่านอนหัวสูง การเฝ้าระวังสายระบายเลือด pain management สิ่งที่ดีติดไปกับผู้ป่วย
☐ ผู้ป่วยมีปัญหาดังต่อไปนี้ ระบุ.....
☐ สิ่งที่ต้องระวังหลังการผ่าตัด คือ.....
- การจำหน่าย/ ส่งต่อผู้ป่วย
☐ กลับบ้าน
☐ กลับหอผู้ป่วย.....
☐ รับไว้เป็นผู้ป่วยใน หอผู้ป่วย.....

OR-ICU/ward

เอกสาร E

การส่งต่อข้อมูลของพยาบาลห้องผ่าตัดกับพยาบาลไอซียู/หอผู้ป่วย

- ชื่อ..... นามสกุล.....อายุ..... HN.....
- โรค.....
- การทำผ่าตัด/หัตถการ.....
- Respiratory system ☐ ใส่ tube ☐ ไม่ใส่ tube
- EBL.....ml.
Blood component ที่ได้รับ.....
ที่คงเหลือ.....
- Drain/Catheter.....
(เช่น NG-tube, Jackson's drain, Vacuum drain, Foley catheter เป็นต้น)
- Fluid/Drug.....
- V/S (ล่าสุดก่อนย้ายไป ICU/หอผู้ป่วย).....
- ข้อควรระวังเป็นพิเศษ/ดูแลต่อเนื่อง (เช่น ห้ามทำหัตถการบริเวณ.....
ห้ามกดทับบริเวณ..... มี stent บริเวณ..... Contact precaution)



Do Safety Checklists Improve Teamwork and Communication in the Operating Room? A Systematic Review

Russ, Stephanie PhD; Rout, Shantanu MRCS; Sevdalis, Nick PhD; Moorthy, Krishna MD, FRCS; Darzi, Ara MD, FRCS, FACS; Vincent, Charles PhD

Author Information

Annals of Surgery 258(6):p 856-871, December 2013. | DOI: 10.1097/SLA.0000000000000206

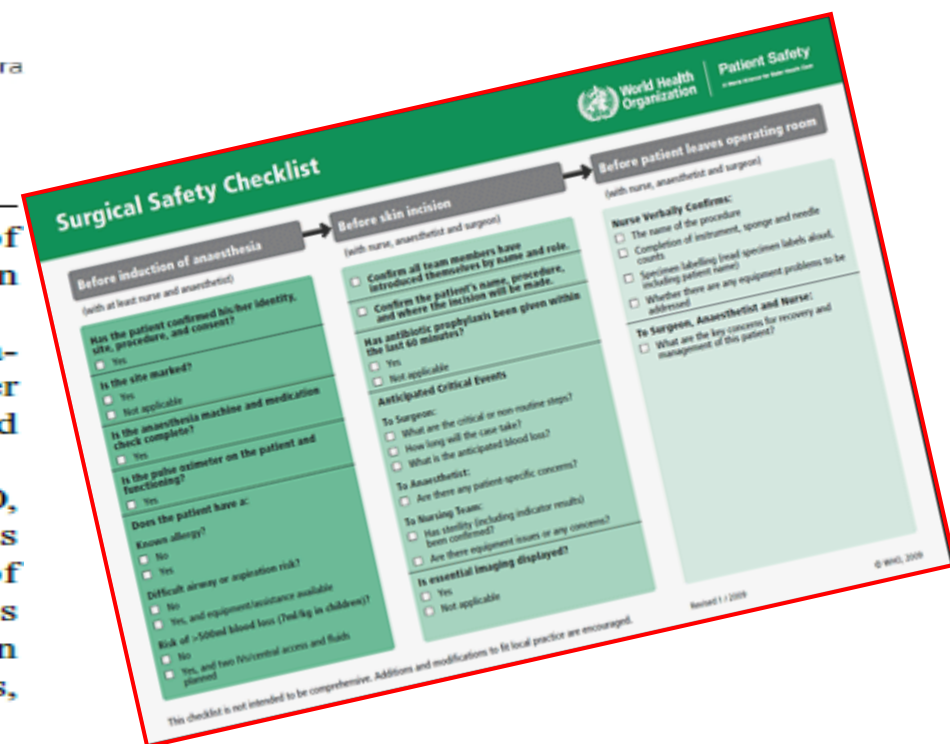
Objectives: The aim of this systematic review was to assess the impact of surgical safety checklists on the quality of teamwork and communication in the operating room (OR).

Background: Safety checklists have been shown to impact positively on patient morbidity and mortality following surgery, but it is unclear whether this clinical improvement is related to an improvement in OR teamwork and communication.

Methods: A systematic search strategy of MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, Google Scholar, and the Cochrane Database for Systematic Reviews was undertaken to obtain relevant articles. After de-duplication and the addition of limits, 315 articles were screened for inclusion by 2 researchers and all articles meeting a set of prespecified inclusion criteria were retained. Information regarding the type of checklist, study design, assessment tools used, outcomes, and study limitations was extracted.

Results: Twenty articles formed the basis of this systematic review. All articles described an empirical study relating to a case-specific safety checklist for surgery as the primary intervention, with some measure of change/improvement in teamwork and/or communication relating to its use.

The methods for assessing teamwork and communication varied greatly, including surveys, observations, interviews, and 360° assessments. The evidence suggests that safety checklists improve the perceived quality of OR teamwork and communication and reduce observable errors relating to poor team skills. This is likely to function through establishing an open platform for communication at the start of a procedure: encouraging the sharing of critical case-related information, promoting team coordination and decision making, flagging knowledge gaps, and enhancing team cohesion. However, the evidence would also suggest that when used suboptimally or when individuals have not bought in to the process, checklists may conversely have a negative impact on the function of the team.



เราทำอย่างไร เพื่อให้ทีมผ่าตัดหยุดฟังเรา ?



A checklist that is completed mechanically may provide documentation,

but it may not provide safety.

A time-out that is rushed may satisfy a policy, *but it may fail to protect the patient.*

Consistent and meaningful use of tools does its matters !!



2) การมอบหมายหน้าที่ตามตำแหน่งงานในขั้นตอนสำคัญ



Completed before move :OR

RN 2

- Special device
- Special positioning

Surgeon

Anesthe siologist

RN 1

- Sign out
 - Specimen,
 - swab, instrument
 - **Specific problem***
- Surgical wound
- Skin injury
- Complication

Percussionist / Technician



PN

- Drain
- Foley catheter
- Warming
- Other Device

Completed doc. & ***Call for hand off***

2) การมอบหมายหน้าที่ตามตำแหน่งงานในขั้นตอนสำคัญ



Completed before move: RR



RN 1

- Check D/C criteria
- IV fluid
- surgical wound
- Complication
- **Specific problem***
- Completed doc.

PN

- Drain
- Foley catheter
- Warming
- O2 cylinder
- ประสานงาน
ทีมเคลื่อนย้าย

RN 2

- Special positioning
- Special device, O2 device

Completed doc. & **Call for hand off**

3) สร้างแนวทางปฏิบัติ Early warning sign (Concurrent trigger tool)



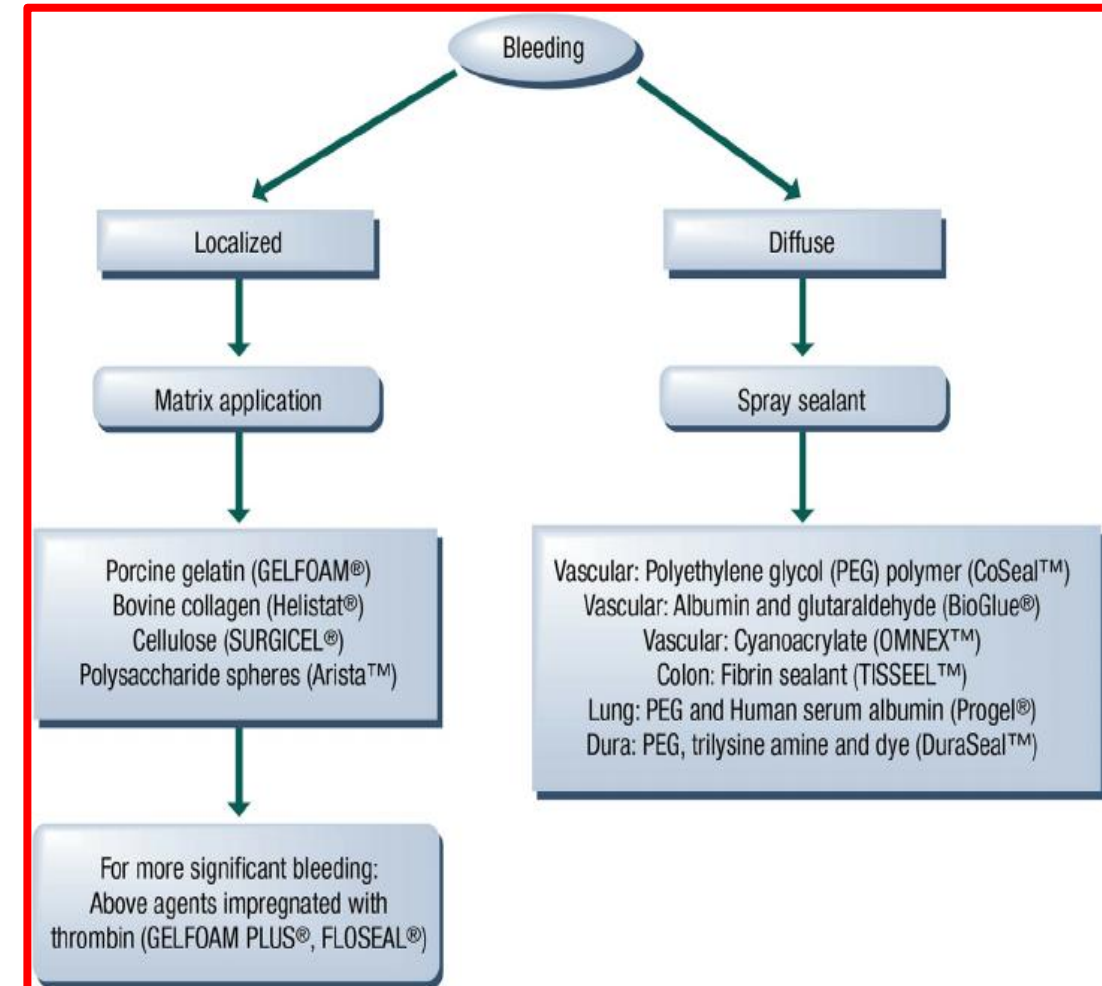
Preoperative Assessment

Assessment risk factors related bleeding

- Previous anemia , Hemophilia
- Coagulation prolong
- Comorbidity related hemostasis: Cancer, Liver disease, ESRD, Coagulation factor deficit, DM
- Anticoagulant drugs: Aspirin, Warfarin, Clopidogrel (PLAVIX), Heparin
- Elderly
- Hypothermia (platelet dysfunction)

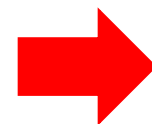


Prothrombin time (PT)	11-13 seconds
International normalized ratio (INR)	0.8-1.1

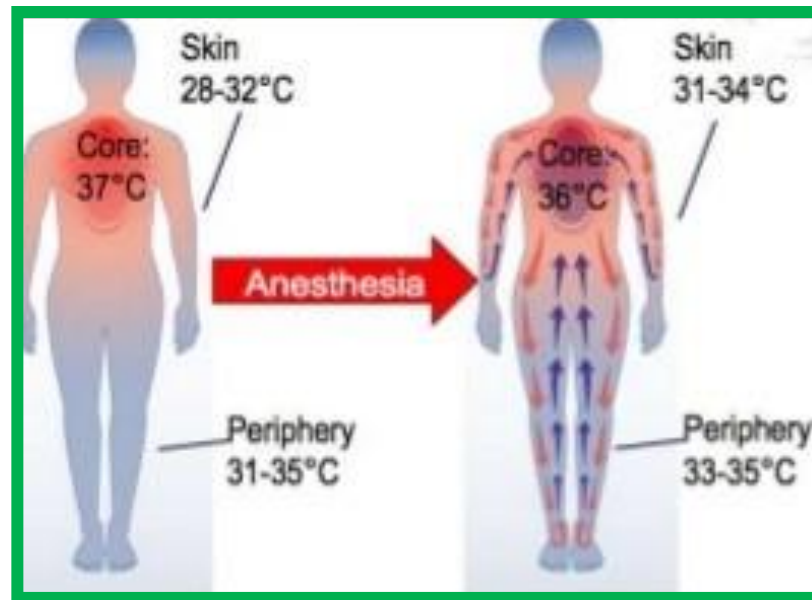


Risk factor for Hypothermia

- Pre-operative Hypothermia ($<36^{\circ}\text{C}$)
- Age > 60 year old
- BMI
- ASA >1
- Operative time >2 hrs.
- General Anesthesia
- Intra-operative irrigation
- Current High blood loss



Pre warming



MEWS : Perioperative Pressure related Injury Prevention

OR Skin Bundle

Scott Triggers®

- Age >62
- Albumin <3.5 or
- BMI <19 or >40
- ASA Score ≥3
- Time on the table ≥3 hr

Score 2 or more =
HIGH RISK

- Skin assessment pre-op and post-op
- Safe patient handling
- High specification OR table pads
- Off loading pressure i.e. heels
- Use special padding for high risk body areas
- Use only approved positioning devices
- Maintain normothermia & microclimate
- Skin Care: Protective dressings
- MDrPUs & MARSI prevention
- Handoff communication
- Post op:
 - Early movement
 - Daily skin assessment
 - Pressure management

Black J, Fawcett D. Scott S Ten top tips: Preventing pressure ulcers in the surgical patient. *Wounds International* 2014;5(4).

http://www.woundsinternational.com/pdf/content_11478.pdf. Accessed February 10, 2015.

Scott S. Progress and Challenges in Perioperative Pressure Ulcer Prevention. *J Wound Ostomy Continence Nurs.* 2015;42(5):480-485.

Scott S. Creating a strategic plan for perioperative pressure ulcer prevention. *AORN Journal* 2016;103(4):13-14.

วัตถุประสงค์ : ป้องกันการเกิดแผลกดทับในห้องผ่าตัด

KPI

1. อัตราการใช้ MEWS ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ≥80%

2. อุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับในห้องผ่าตัด = 0 ราย



แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในห้องผ่าตัด:
Siriraj Concurrent Trigger Tool: Modify Early Warning Sign
For Perioperative Pressure Injury Prevention (1)

หน่วยผ่าตัด.....

Sticker ผู้ป่วย/วันที่.....



Pre-operative (VR)

Assessment: Risk Factors and Previous Pressure Injury

☐ No

☐ Yes

High Risk (2)

☐ No

☐ Yes

Standard Nursing Care

Intra-operative (OR)

OR Skin Prevention Bundle (3)

- ☐ Maintenance of normothermia
- ☐ Positioning Devices
- ☐ Polyurethane foam dressing
- ☐ Off load heels
- ☐ Support surface

Post-operative (OR/RR)

Assessment: Skin changes (4) and Pressure Injury (5)

☐ No

☐ Yes

Skin changes (4) / Pressure Injury (5)

- ☐ Early Re-positioning (6)
- ☐ Change positions of medical devices (7)
- ☐ Notify surgeon
- ☐ Standard Nursing Care Pressure injury
- ☐ Notify ward

Previous Pressure Injury : ☐ No

☐ Yes : Stage... Size.....

Risk Factors (4) : High Risk ≥ 2 Factors (2)

☐ No

☐ Yes

- ☐ Age ≥ 62
- ☐ BMI < 19 or > 40
- ☐ Albumin < 3.5 g/L
- ☐ American Society of Anesthesiologists (ASA) score ≥ 3
- ☐ Operative time ≥ 3 hrs
- ☒ Prone position

Skin changes

☐ No

☐ Yes

- ☐ Redness Site..... ☐ OR ☐ RR
- ☐ Bruising Site..... ☐ OR ☐ RR
- ☐ Edema Site..... ☐ OR ☐ RR
- ☐ Darkly skin area Site..... ☐ OR ☐ RR
- ☐ Pain Site..... ☐ OR ☐ RR

Pressure Injury

☐ No

☐ Yes

- ☐ Pressure injury at 1 Site..... ☐ OR ☐ RR
- ☐ Pressure injury at 2 Site..... ☐ OR ☐ RR
- ☐ DTPI Site..... ☐ OR ☐ RR
- ☐ MDRPI stage... Site..... ☐ OR ☐ RR
- ☐ MMPI Site..... ☐ OR ☐ RR

Summary By: ☐ OR ☐ RR **Transfer To :** ☐ Ward ☐ ICU ☐ Other.....

Skin changes : ☐ No

☐ Yes

- ☐ Redness
- ☐ Bruising
- ☐ Edema
- ☐ Darkly skin area
- ☐ Pain

Diagnosis :

Operation :

Surgical position :

MEWS : Perioperative DVT Prevention



DVT

1. Blood stasis
2. Endothelial injury from surgery
3. Hypercoagulable

Risk factor for DVT

Pneumatic compression devices



- Elderly
- BMI > 40
- ASA ≥ 3
- Pregnancy
- Previous DVT
- Thrombophilia such as deficiency of antithrombin , activated protein C
- Surgery in pulbic cavity, Hip Joint, Knee joint

MEWS: Violence Prevention

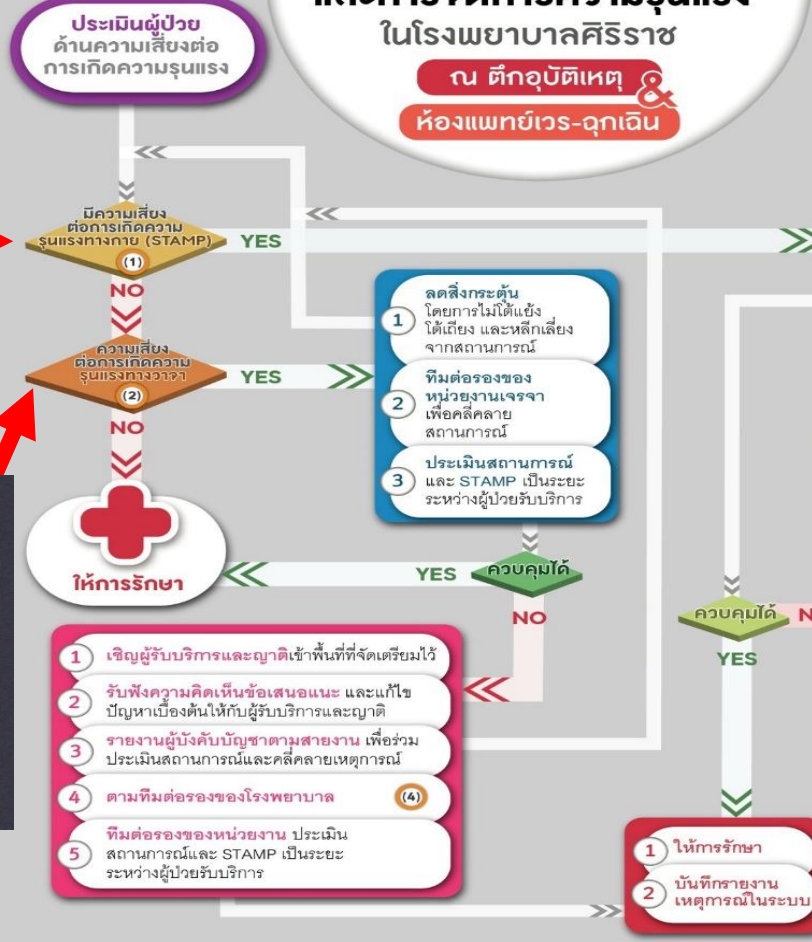


มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

แนวทางการป้องกัน และการจัดการความรุนแรง ในโรงพยาบาลศิริราช ณ ตึกอุบัติเหตุ & ห้องแพทย์เวร-ฉุกเฉิน

- 1 รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย ประมาณ 1.5 เมตรจากผู้ป่วย ไม่เผชิญหน้าตรง ๆ ไม่หันหลังให้
- 2 กำจัดสิ่งกระตุ้น ที่อยู่รอบข้าง
- 3 แจ้งรปภ. หากประเมินว่าอาจมีอาวุธ หรือสิ่งที่เป็นอาวุธ
- 4 ใช้ทีมสำรองของหน่วยงาน เพื่อเคลื่อนย้ายสถานการณ์ (3)
- 5 แพทย์ประเมินผู้ป่วย
- 6 ประสาน รปภ./Code V 97272
- 7 พิจารณาผูกมัดตัวผู้ก่อเหตุ เมื่อใช้วิธีการจัดการวิธีอื่น ๆ แล้วไม่ได้ผล พร้อมอธิบายความจำเป็นแก่ญาติและผู้เกี่ยวข้องกับผู้ก่อเหตุ ตามแนวปฏิบัติของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- 8 พิจารณาปรึกษาจิตแพทย์ร่วมประเมินผู้ป่วย (ในเวลาราชการ) 97373 (นอกเวลาราชการ) 97777 (5)
- 9 ทีมสำรองของหน่วยงานประเมินสถานการณ์เป็นระยะ ระหว่างผู้ป่วยรับบริการ

- 1 กรณีผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่ พิจารณาให้ยา Haloperidol 2.5-5 mg IM และ Midazolam 3-5 mg ชีตเข้ากล้ามเนื้อ
- 2 กรณี Physical violence
 - 2.1 รายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงาน เพื่อร่วมประเมินสถานการณ์และเคลื่อนย้ายเหตุการณ์
 - 2.2 ตามทีมสำรองของโรงพยาบาล (4)
 - 2.3 รปภ. พิจารณาประสานตำรวจในพื้นที่ระงับเหตุ (หากมีสถานการณ์ที่เสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อระบบรุนแรง ควรแจ้งให้ผู้คนออกจากพื้นที่)
 - 2.4 พิจารณาปรึกษานิติกร และฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ เมื่อบุคลากรมีการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินของโรงพยาบาลเสียหาย



(1) ความเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรง (STAMP)

ข้อใดข้อหนึ่ง

- **Staring and eye contact**
จ้องตามากกว่าปกติ
- **Tone and volume of voice**
พูดจาเสียงดัง/น้ำเสียงแข็งกร้าว
- **Anxiety**
ดูวิตกกังวล
- **Mumbling**
พูดพึมพำอยู่คนเดียว
- **Pacing**
เดินกลับไปกลับมา

(2) ความเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงทางวาจา ข้อใดข้อหนึ่ง

- พูดเสียงดัง
- ต่อกว่า ต่าหนี ดูหมิ่น ข่มขู่ คุกคามผู้ให้บริการ
- คำพูดที่แสดงความไม่พอใจในบริการ
- มีประวัติความรุนแรง เช่น ต่อยตีกันก่อนมารพ.

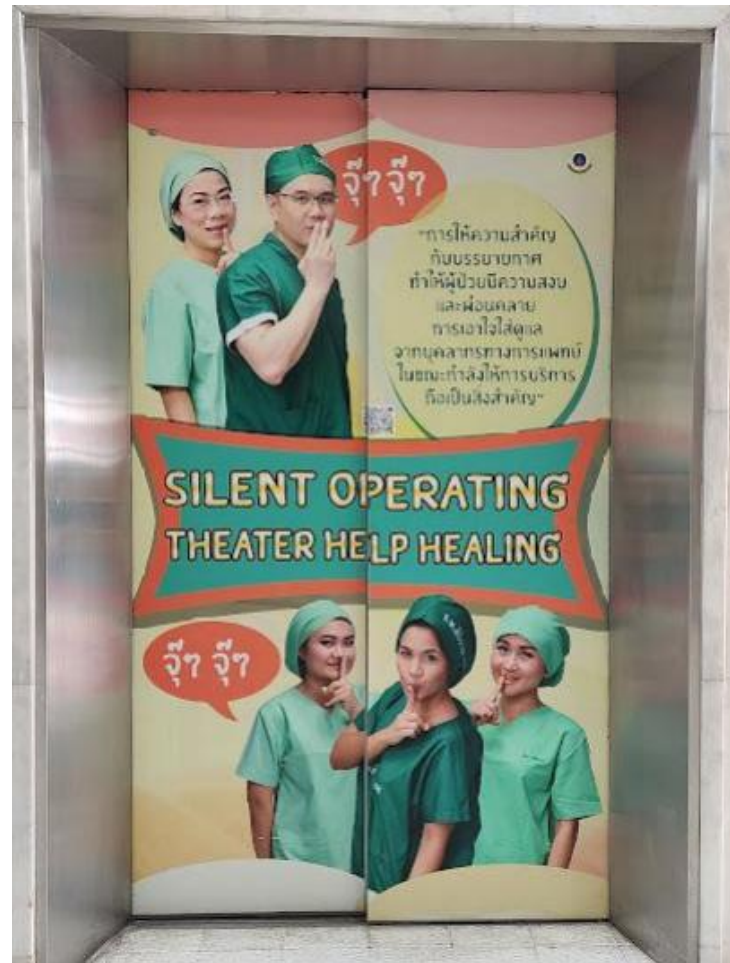
ความเสี่ยงต่อการเกิด ความรุนแรง (STAMP) ข้อใดข้อหนึ่ง - Staring and eye contact จ้องตามากกว่าปกติ - Tone and volume of voice พูดจาเสียงดัง/น้ำเสียงแข็งกร้าว - Anxiety วิตกกังวล - Mumbling พูดพึมพำคนเดียว - Pacing เดินกลับไปกลับมา	ความเสี่ยงต่อการเกิด ความรุนแรงทางวาจา ข้อใดข้อหนึ่ง - พูดเสียงดัง - ต่อกว่า ต่าหนี ดูหมิ่น ข่มขู่ คุกคามผู้ให้บริการ - คำพูดที่แสดงความไม่พอใจในบริการ - มีประวัติความรุนแรง เช่น ต่อยตีกันก่อนมารพ.	ทีมสำรองหน่วยงาน 'ได้แก่' หัวหน้าทีม/ หัวหน้าเวร/หัวหน้าหอ - ทีมสำรองโรงพยาบาล 'ได้แก่' - ในเวลาราชการ) แจ้งที่: งานบริหารจัดการความเสี่ยง 99655 (นอกเวลาราชการ) รายงาน: ผอ.นอกเวลาราชการ 97777	เกณฑ์ในการปรึกษา จิตแพทย์ - มีประวัติโรคทางจิตเวช - มีอาการหวาดระแวง กลัว - มีพฤติกรรมพูดคนเดียว ชูแว่ว หรือเห็นภาพหลอน - มีประวัติการใช้สารเสพติด - เศร้า ปั่นอยากตาย
* พิจารณาปรึกษานิติกร กรณีบุคลากรมีการบาดเจ็บ 99857 หรือ 98054 (ในเวลาราชการ)	ปรึกษาฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ กรณีทรัพย์สินสูญหาย 99816 หรือ 99987 (ในเวลาราชการ)	หมายเหตุ: การประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยงด้านผู้ติดตาม/ผู้ส่ง กลุ่มคนที่อาจก่อเหตุซ้ำโดยรปภ. เอกสารแนบ 1-2	

4) สร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันที่ดี



ความเงียบในขณะผ่าตัด (Soft power)

การให้ความสำคัญกับบรรยากาศย่อมส่งผลดีต่อการรักษาพยาบาล





การศึกษาการถูกขัดจังหวะงานสำคัญของพยาบาลช่วยรอบนอก ในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย*

รัตติมา ศิริไธราษฎร์, PhD¹ อุษาวดี วัชรวิเศษ, PhD¹ ศิวพร กือชาติ, พย.ม.² มนวัฒน์ เอนฉ่ำ, วท.ม.²

ผลการวิจัย: ผลจากการสังเกตการทำงานของพยาบาลช่วยรอบนอกในการผ่าตัดจำนวน 99 ราย ณ ห้องผ่าตัด พบว่า ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการผ่าตัด เท่ากับ 155.1 นาที (SD = 77.2) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 86.9 อายุเฉลี่ย 41.1 ปี (SD = 9.69) บทบาทการให้บริการเป็นพยาบาลร้อยละ 56.6 และผู้ช่วยพยาบาลร้อยละ 43.4 โดยภาพรวมพบว่า การถูกขัดจังหวะขณะปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดรวม 446 ครั้ง โดยแหล่งที่มาของการถูกขัดจังหวะมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ คนเดินเข้า-ออกในห้องผ่าตัด (153 ครั้ง หรือร้อยละ 34.3) รองลงมา คือ โทรศัพท์/วิทยุติดตามตัว/วิทยุ (118 ครั้ง หรือร้อยละ 26.45) และการพูดคุยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดเกิดขึ้นเป็นอันดับที่ 3 (72 ครั้ง หรือร้อยละ 16.14) และการพูดคุยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดมีผลกระทบต่องานของผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานมานานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = .033$)

สรุปและข้อเสนอแนะ: การศึกษาครั้งนี้พบการถูกขัดจังหวะเป็นจำนวนบ่อยครั้งในระหว่างการปฏิบัติงานสำคัญ ควรพัฒนาแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการป้องกัน/ลดการถูกขัดจังหวะขณะปฏิบัติงาน และอบรมให้พยาบาลช่วยรอบนอกมีความรู้ และทักษะในการจัดการกับการถูกขัดจังหวะขณะปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

Observational study

การถูกขัดจังหวะในงานสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่

- 1) การนับผ้าชั้นโลหิตและเครื่องมือผ่าตัดครั้งแรก
- 2) การทำ Time out
- 3) การนับผ้าชั้นเลือดและเครื่องมือครั้งสุดท้าย

ระดับ	ลักษณะของผลกระทบที่เกิดจากการถูกขัดจังหวะ
1	เกิดสิ่งรบกวนที่สามารถนำไปสู่การเกิดการขัดจังหวะขึ้นในห้องผ่าตัด เช่น เสียงโทรศัพท์ แต่พยาบาลช่วยรอบนอกไม่ตอบสนองต่อสิ่งรบกวนเหล่านั้น
2	พยาบาลช่วยรอบนอกหยุดปฏิบัติงานหลักแล้วตอบสนองต่อสิ่งรบกวนที่มาขัดจังหวะ
3	พยาบาลช่วยรอบนอกปฏิบัติงานหลักพร้อมกับตอบสนองต่อสิ่งรบกวนที่มาขัดจังหวะพร้อมๆ กัน (multitasking)
4	สิ่งรบกวนที่เข้ามาขัดจังหวะทำให้เกิดการหยุดชะงักของการผ่าตัด

ตารางที่ 2 จำนวนความถี่ของการถูกขัดจังหวะ จำแนกตามแหล่งที่มาและระดับผลกระทบของการถูกขัดจังหวะ

แหล่งที่มา	ผลกระทบของการถูกขัดจังหวะ				
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	รวม (ร้อยละ)
คนเดินเข้า-ออก ห้องผ่าตัด	149	4	0	0	153 (34.3)
โทรศัพท์/วิทยุ/เครื่องมือสื่อสาร	99	15	4	0	118 (26.45)
การพูดคุยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด	58	10	4	0	72 (16.14)
เครื่องมือมีปัญหา	7	0	6	0	13 (2.91)
การเรียนการสอนในห้องผ่าตัด	40	2	1	0	43 (9.64)
อื่นๆ (การส่งเวร เครื่องมือตก ต่ออุปกรณ์)	4	11	32	0	47 (10.53)
รวม	357	42	47	0	446

ตารางที่ 3 จำนวนความถี่ของการถูกขัดจังหวะ จำแนกตามลักษณะงานสำคัญ และระดับผลกระทบของการถูกขัดจังหวะ

ลักษณะงานสำคัญ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	รวม (ร้อยละ)
การนับผ้าซับเลือดและเครื่องมือครั้งแรก	150	13	19	0	182 (40.81)
การทำ Time out	93	6	18	0	117 (26.23)
การนับผ้าซับเลือดและเครื่องมือครั้งสุดท้าย	123	14	10	0	147 (32.96)
รวม	366 (82.06)	33 (7.40)	47 (10.54)	0	446 (100.00)

5) Safety Awareness culture



เราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้บ้าง ??



Morning OR team huddle



the day's case load, including the status of specific patients and the procedures planned for the day's scheduled surgeries at Naval Hospital Bremerton



The best Unit Safety Huddle Operations in MEDCOM, General Leonard Wood Army Community Hospital



Bulletin of the American Collage of Surgeon

Safety Awareness Culture



Morning Briefing / Huddle up

- 1) วันนี้มี case ไหนต้องเตรียม/ ระวัง อะไรเป็นพิเศษ ?
- 2) เพราะอะไร ?
- 3) ต้องเตรียมความพร้อม/ ต้องทำอะไรบ้าง ?

After Action Review (AAR)

- 1) เมื่อวานมีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่ได้ คาดหมายไหม ?
- 2) เพราะอะไร ?
- 3) แล้วต่อไป เราต้องทำอะไร เพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ?

พูดคุยกันเร็ว Recall ได้ ➡ จำเข้าสมองได้ ➡ เกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น
➡ ลดข้อผิดพลาด/ คลาดเคลื่อนได้ดี



Today is:

Huddle Board

	Unit	House
Census		
Expected Discharges		
Other _____		



Quote of the Week:

Safety Section:

Number of Days Since Last ...	Unit	House
Serious Safety Event (SSE)		
Employee Injury		

Patient Experience/Quality Metrics/Hand Hygiene:

Topic	Unit	House

Upcoming Events/
Announcements/Reminders:

Great Catches/Recognition:

Maintenance/Environmental Issues:

Department Focus/Opportunities:

Concern:

Action Plan:

Resolution:



ต้นแบบ Safety Awareness

พฤติกรรมสำคัญที่พบ

- 1) ดักจับความเสี่ยงได้เร็ว และจัดการได้เหมาะสม = มีความรู้ & Technical skills & Non technical skills ดี
- 2) รอบคอบ ตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งของตนเอง และน้องที่ดูแล
- 3) กล้ารายงานความผิดปกติ กล้าแสดงความคิดเห็น
- 4) ช่างสังเกต
- 5) ไม่ละเลย ไม่ปล่อยผ่าน
- 6) มีความ integrity สูง
- 7) ใช้คำพูด กริยาท่าทางการสื่อสารกับผู้ป่วยได้ดี และสม่ำเสมอ

การพัฒนา Non Technical skills



การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

- 1) Education & Training บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
 - บรรยายทฤษฎี มโนทัศน์ของ NTS
 - workshop วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง (Scenario)
 - Simulation , Role play
- 2) กำหนด **NTS** ในการประเมิน Specific Functional Competency บุคลากร
- 3) **Multidisciplinary training** → **IPE**

การจัดระบบ/นโยบาย/ แนวทางปฏิบัติ

- 1) มีเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างทีมที่ชัดเจน
 - Surgical Safety Checklist, **Briefing**
 - Hand off Dialog, **ISBAR**
- 2) การมอบหมายหน้าที่ตามตำแหน่งงานในขั้นตอนสำคัญ
- 3) สร้างแนวทางปฏิบัติ Early warning sign (Concurrent trigger tool)
- 4) สร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันที่ดี
- 5) สร้าง **Safety Awareness culture**
 - Morning briefing, **Huddle up**
 - Robust Safety reminder หาดันแบบ

Monitor & Evaluation

- ประเมิน **Specific Functional Competency** ระดับบุคคล และผลลัพธ์การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
- ติดตามตัวชี้วัด Safety score โดย **KPI Board** ทุกหน่วยงาน (ระดับ A-B เพิ่มขึ้น OK) วิเคราะห์ RCA โดยเฉพาะ Human factor

สถิติการทำ Self Audit-Sign Out



ข้อมูลตั้งแต่ 7 ก.พ. 2565 – 30 ก.ย. 2566

% การทำ Self Audit-Sign Out จำแนกรายเดือน แยกตามสาขา

	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65
Acute Care	85.71%(6/7)	87.50%(7/8)	80.00%(12/15)	66.67%(14/21)	82.35%(14/17)	91.67%(11/12)	54.55%(6/11)	94.12%(16/17)	75.00%(6/8)	64.29%(9/14)	87.50%(21/24)
Cardiovascular Th.	61.80%(55/89)	78.08%(114/146)	72.82%(75/103)	83.59%(107/128)	77.34%(99/128)	84.34%(70/83)	68.18%(90/132)	80.92%(106/131)	75.22%(85/113)	66.96%(77/115)	76.11%(86/113)
ENT	95.33%(204/214)	94.43%(271/287)	87.92%(211/240)	92.18%(271/294)	93.99%(297/316)	87.76%(215/245)	89.28%(308/345)	91.12%(318/349)	92.96%(251/270)	94.59%(280/296)	91.67%(242/264)
General : Colorectal	64.86%(24/37)	73.44%(47/64)	78.72%(37/47)	81.82%(45/55)	89.55%(50/57)	83.72%(36/43)	85.29%(58/68)	85.19%(69/81)	96.23%(51/53)	97.92%(47/48)	95.16%(59/62)
General : HPB	67.39%(31/46)	73.53%(50/68)	87.18%(34/39)	91.18%(62/68)	87.67%(64/73)	82.76%(48/58)	72.15%(57/79)	93.85%(61/65)	80.77%(42/52)	91.07%(51/56)	96.67%(58/60)
General : MIS	78.79%(52/66)	85.71%(66/77)	86.42%(70/81)	89.19%(66/74)	84.81%(67/79)	88.06%(59/67)	81.91%(77/94)	87.50%(84/96)	94.81%(71/77)	88.57%(62/70)	94.44%(68/72)
Gynaecology	57.22%(103/180)	85.28%(126/265)	84.95%(175/206)	85.31%(209/245)	77.90%(208/267)	86.92%(186/214)	90.46%(237/262)	91.77%(290/316)	88.54%(224/253)	89.11%(221/248)	83.02%(220/265)
Head Neck and Br.	91.67%(110/120)	93.48%(172/184)	93.02%(120/129)	92.86%(168/182)	95.71%(201/210)	95.27%(141/148)	81.82%(162/198)	80.10%(157/196)	89.02%(146/164)	89.17%(140/157)	89.72%(154/166)
Neuro	88.89%(72/81)	82.68%(105/127)	83.33%(80/96)	87.39%(104/119)	90.43%(104/115)	95.96%(95/99)	90.48%(95/105)	95.38%(124/130)	93.20%(96/103)	92.31%(108/117)	96.19%(101/105)
Obstetrics	75.95%(60/79)	73.11%(87/119)	80.00%(64/80)	83.81%(106/113)	88.80%(111/125)	85.58%(89/104)	89.23%(116/130)	91.85%(124/135)	81.20%(95/117)	82.05%(96/117)	86.67%(104/120)
Ophthalmology	106.37%(384/361)	99.49%(581/584)	99.55%(446/448)	99.48%(571/574)	98.79%(570/577)	99.48%(384/386)	98.41%(557/566)	98.86%(608/615)	98.53%(537/545)	99.22%(512/516)	99.29%(560/564)
OR Minor	18.97%(37/195)	100.00%(306/306)	99.60%(250/251)	100.00%(284/284)	100.00%(360/360)	100.00%(291/291)	100.00%(322/322)	99.72%(351/352)	100.00%(301/301)	95.27%(302/317)	100.00%(271/271)
Orthopedics	82.80%(231/279)	87.65%(362/413)	82.91%(296/357)	91.44%(374/409)	95.14%(431/453)	84.31%(301/357)	88.86%(375/422)	94.46%(392/415)	88.89%(320/360)	92.11%(362/392)	90.96%(342/376)
Pediatric	101.30%(78/77)	84.04%(79/94)	84.00%(63/75)	90.22%(83/92)	89.80%(88/98)	88.54%(85/96)	90.20%(92/102)	90.91%(80/88)	93.94%(93/99)	93.27%(97/104)	93.81%(91/97)
Plastic	80.74%(109/135)	91.38%(159/174)	92.36%(145/157)	91.02%(152/167)	93.37%(169/181)	86.16%(137/159)	87.21%(150/172)	93.68%(163/174)	87.13%(149/171)	90.85%(129/142)	94.89%(130/137)
Trauma	102.54%(35/34)	86.21%(50/58)	98.00%(49/50)	89.66%(52/58)	93.24%(69/74)	90.59%(77/85)	91.67%(110/120)	90.48%(95/105)	92.86%(91/98)	92.86%(91/98)	92.63%(88/95)
Urology	43.38%(95/219)	63.70%(179/281)	62.00%(155/250)	65.06%(175/269)	70.30%(213/303)	62.34%(149/239)	65.85%(214/325)	63.14%(197/312)	70.26%(189/269)	65.06%(188/289)	65.00%(182/280)
Vascular	91.09%(92/101)	88.89%(128/144)	89.52%(94/105)	86.39%(127/147)	91.86%(158/172)	87.50%(98/112)	92.86%(156/168)	93.04%(147/158)	95.28%(121/127)	92.03%(127/138)	90.52%(105/116)

	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
Acute Care	94.12%(16/17)	91.67%(11/12)	70.37%(19/27)	92.31%(12/13)	100.00%(13/13)	100.00%(22/22)	84.21%(16/19)	95.00%(19/20)	95.45%(21/22)
Cardiovascular Th.	87.07%(101/116)	81.25%(91/112)	81.42%(92/113)	80.68%(71/88)	84.64%(106/112)	87.60%(106/121)	91.35%(95/104)	96.69%(111/116)	84.87%(101/119)
ENT	95.07%(328/345)	96.36%(318/330)	94.44%(306/324)	94.32%(249/264)	92.11%(292/317)	92.15%(317/344)	97.16%(308/317)	92.84%(324/349)	93.71%(328/350)
General : Colorectal	85.44%(51/59)	97.10%(67/69)	92.96%(66/71)	90.51%(40/44)	95.92%(47/49)	100.00%(58/58)	100.00%(51/51)	94.83%(55/58)	90.77%(55/65)
General : HPB	91.67%(55/60)	98.33%(59/60)	97.06%(66/68)	96.00%(48/50)	93.10%(54/58)	95.38%(62/65)	98.63%(72/73)	92.96%(66/71)	94.83%(55/58)
General : MIS	91.03%(71/78)	93.07%(94/101)	92.21%(71/77)	92.75%(64/69)	94.25%(82/87)	97.14%(68/70)	88.89%(72/81)	92.21%(71/77)	96.91%(94/97)
Gynaecology	87.81%(245/279)	91.14%(247/271)	86.46%(249/288)	77.92%(187/240)	89.49%(247/276)	91.48%(290/317)	90.60%(289/319)	93.14%(285/306)	89.27%(258/289)
Head Neck and Br.	93.85%(168/179)	94.22%(163/173)	96.32%(183/190)	97.04%(131/135)	95.29%(162/170)	96.76%(179/185)	97.94%(190/194)	97.19%(173/178)	98.50%(197/200)
Neuro	93.40%(99/106)	92.00%(115/125)	90.18%(101/112)	90.48%(76/84)	94.26%(115/122)	97.50%(117/120)	94.83%(110/116)	94.50%(103/109)	94.64%(106/112)
Obstetrics	88.68%(141/159)	88.78%(87/98)	85.92%(122/142)	87.96%(95/108)	91.60%(109/119)	91.61%(131/143)	84.92%(107/126)	84.43%(103/122)	79.72%(114/143)
Ophthalmology	98.82%(587/594)	99.18%(603/608)	98.58%(694/704)	99.26%(537/541)	100.00%(608/608)	99.31%(578/582)	98.98%(485/490)	99.15%(583/588)	99.38%(645/649)
OR Minor	98.68%(299/303)	98.71%(307/311)	100.00%(318/318)	99.63%(267/268)	100.00%(307/307)	99.67%(300/301)	99.06%(317/320)	100.00%(315/315)	100.00%(291/291)
Orthopedics	93.64%(368/393)	97.60%(366/375)	93.64%(427/456)	88.10%(296/336)	91.69%(364/397)	95.25%(361/379)	89.33%(385/431)	77.40%(363/469)	80.48%(404/502)
Pediatric	90.20%(92/102)	92.31%(84/91)	98.18%(108/110)	87.50%(77/88)	85.85%(91/106)	85.71%(84/98)	90.83%(99/109)	88.15%(106/108)	97.25%(106/109)
Plastic	100.00%(150/150)	94.55%(156/165)	93.60%(161/172)	86.16%(137/159)	91.67%(176/192)	94.58%(192/203)	96.43%(162/168)	93.96%(171/182)	95.17%(197/207)
Trauma	90.53%(86/95)	95.00%(76/80)	88.50%(100/113)	94.37%(67/71)	91.36%(74/81)	95.18%(79/83)	92.39%(85/92)	96.91%(94/97)	96.10%(74/77)
Urology	71.48%(213/298)	64.76%(216/332)	71.30%(231/324)	62.45%(143/229)	67.63%(211/312)	69.62%(220/316)	62.38%(189/303)	63.10%(212/336)	65.28%(220/337)
Vascular	88.46%(138/156)	95.48%(148/155)	85.27%(110/129)	91.89%(102/111)	93.42%(142/152)	91.03%(132/145)	85.51%(118/138)	94.52%(138/146)	89.26%(133/149)

ขยายความระดับความปลอดภัยขององค์กร

Safety Culture Evolution



complacent หมายความว่า ชะล่าใจ หรือ ใต้ใจ หรือ
เหินใจ ซึ่งคือรู้สึกว่าได้และพอใจอยู่แล้วเลยประมาณได้

NEW !!

Risk Base Thinking (Proactive & Predictive RM)



1.Objective.....KPITarget.....



โอกาสเกิด

3.สิ่งคุกคาม
4.สาเหตุทำให้เกิด

5.มาตรการเพื่อการป้องกัน ลดโอกาสเกิด

7.มาตรการกู้กลับคืน /บรรเทา

6.ความสูญเสีย /เสียหาย

2.เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

Hazardous Event

ผลการควบคุม
8.โอกาสและผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ

Consequence
Consequence
Consequence

น้องนุช ภูมิสนธิ์

Leading KRI

Potential Measures

9.อะไรเป็นตัวบอกว่ากำลังจะเกิดสิ่งคุกคามนี้

10.อะไรเป็นตัวบอกว่าเราควบคุมให้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันอยู่

KRI

11.อะไรเป็นตัวบอกว่ากำลังจะเกิดความสูญเสีย/เสียหาย

Recovery Measures

Potential Outcome

Lagging KRI

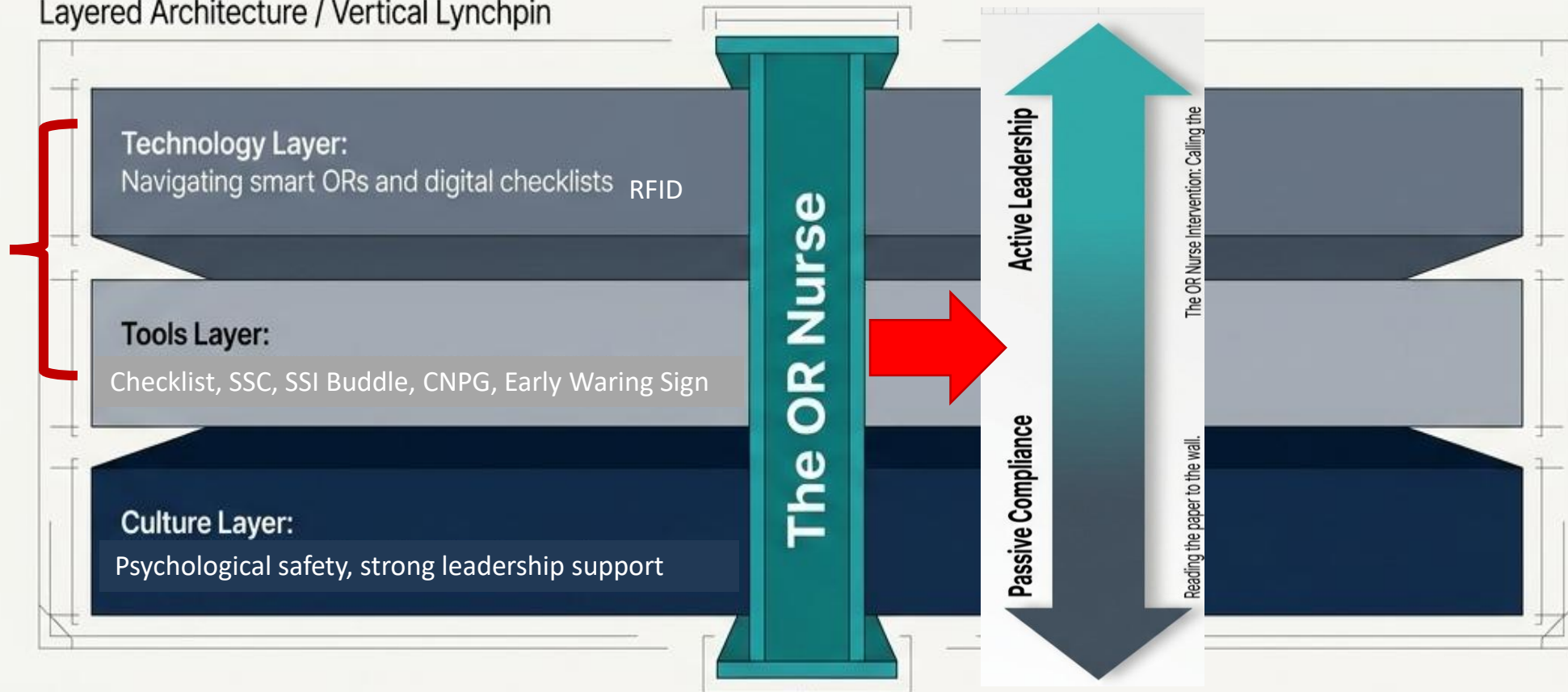
น้องนุช ภูมิสนธิ์

The Operating Room Nurse as the systemic orchestrator



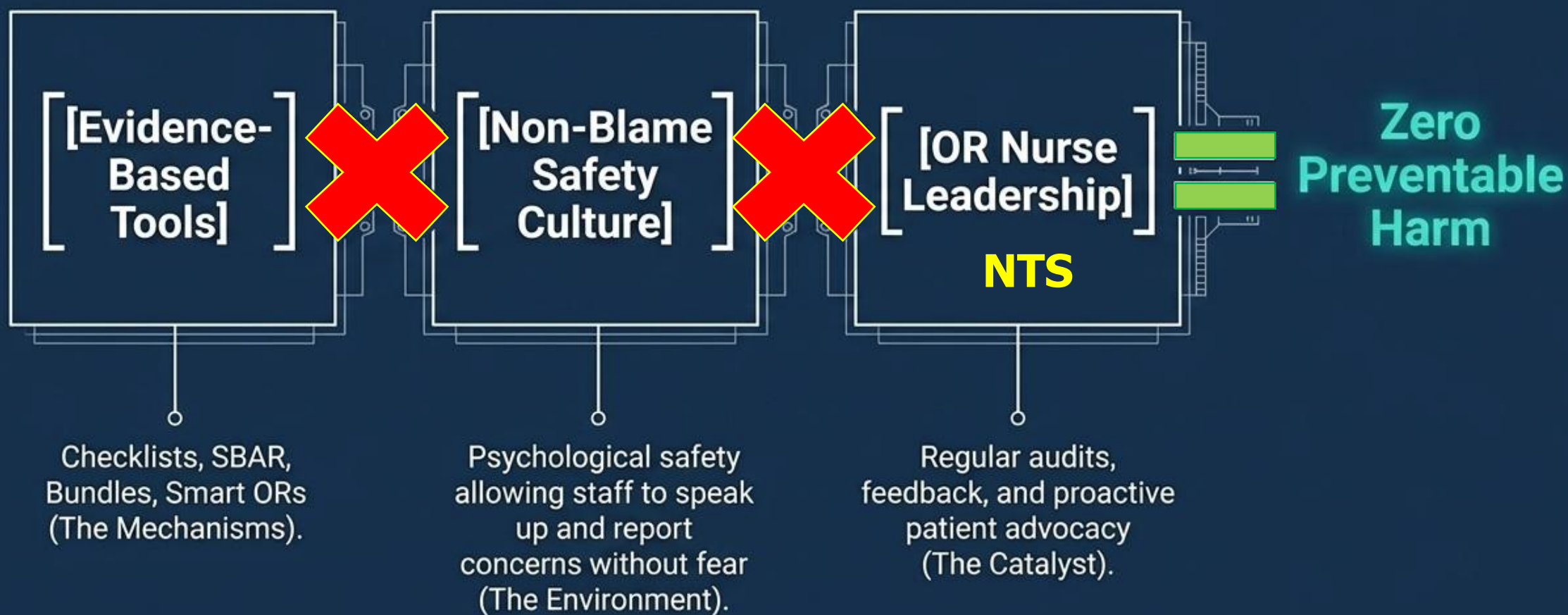
Mechanical
Safety Tool

Layered Architecture / Vertical Lynchpin



Operating room nurses are not just task performers—they are safety leaders. They advocate for the patient, detect risks early, and speak up when something is not right.

The ultimate force multiplier for clinical tools



Operating Room Nurses Are Safety Leaders, Not Task Performers

The Advocate

Uncompromisingly **prioritizing** the **patient's well-being** above operational speed.



The Coordinator

Orchestrating the surgical team to ensure seamless tool utilization.



The Detector

Identifying early warning signs of clinical deterioration or process failure.



The Voice

Speaking up immediately and **assertively** when safety protocols are compromised.



**1) Situation
awareness**

Technical Skills

**2) Effective
Communication
& Teamwork**



**3) Task
Management**

**4) Decision Making
& Leadership**

Thank You

เนื้อหา

- The Future of Digital Surgery
- Enhanced Nursing Collaboration to Nursing outcome
- SDGs Innovation product : Nonwoven draping for Recycle
- Sharing experience & Key success Factors
 - Multidisciplinary team practice to Clinical Practice Guideline: Geriatric Hip Fracture
 - Brother project Liver Transplantation
- Beyond the OR: Future Career Pathways for Perioperative Nurses
- Non-technical skills for patient safety In OR team perspective
- Leading the Future of Perioperative Nursing
- Workshop 4 station
 - station 1 Nursing care in Robotic surgery
 - station 2 Nursing care in Hybrid Surgery
 - station 3 Role of Nurse in Prosthesis & Implant Management
 - station 4 Role of Nurse in Hemostasis management



CONTACT

- สำนักงานการพยาบาลผ่าตัด
- อาคารสยามินทร์ ชั้น 10



Ins. 02-419-7982-3



โครงการ

ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ

Transformation in Perioperative Care : Strategic Collaboration for Safe Surgery and Better Patient Outcomes

ระยะเวลา 2 วัน

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2569

สถานที่



1. ห้องประชุมอวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิราบรมราชชนนี โรงพยาบาลศิริราช
2. ห้องผ่าตัด อาคารสยามินทร์ (workshop)

วัตถุประสงค์



เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทิศทางและการเตรียมความพร้อมทักษะเกี่ยวกับการพยาบาลปรีศัลยกรรม



สร้างเครือข่ายความร่วมมือ การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการพยาบาลปรีศัลยกรรม รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ในการผ่าตัด

เป้าหมาย

1. อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมระดับมากและมากที่สุด $\geq 80\%$
2. อัตราผู้เข้าร่วมประชุมครบตามเกณฑ์ที่กำหนด 100%

ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 300 คน

- พยาบาลห้องผ่าตัดและพยาบาลที่สนใจ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลศิริราช
- ผู้สนใจ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ขอ CNEU จากสภาการพยาบาล

ค่าลงทะเบียน



ประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ

- ฟังการบรรยาย + workshop 3,000 บาท (รับจำนวน 80 คน)
- ฟังการบรรยาย 2,200 บาท

กำหนดการลงทะเบียน

วันที่ 24 สิงหาคม - 30 กันยายน 2569

ขั้นตอนการลงทะเบียน

- ชำระเงินค่าลงทะเบียน ที่บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขาศิริราช
- ชื่อบัญชี สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- เลขบัญชี 016-471205-2 (ตรวจสอบเลขบัญชีก่อนโอน**)



- สมัครลงทะเบียนผ่าน QR Code ลงทะเบียนพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน

QR code ลงทะเบียน

